

대구 골든타임: 소아·고령층 응급의료 접근성 사각지대 진단과 정책 우선검토 후보 도출

— 공공데이터·GIS·취약성 지수 재설계에 기반한
시민주도형 정책분석 프로젝트 —

이현석

실무형 AI·SW 인재 육성 Lab(수성알파시티) 교육생
'대구 골든타임' 개발 프로젝트

2026년 7월

본 보고서는 대구광역시 수성구가 주최하고 (사)한국커리어혁신진흥원이 운영하는
'실무형 AI·SW 인재 육성 Lab' 교육과정의 실무 프로젝트 산출물로 작성되었음.

요 약

[문제] 소아 진료는 낮은 수가·분쟁 부담·수요 기반 축소가 중첩된 시장실패 영역으로, 소아청소년과 의원은 2025년 한 해 개업 59곳 대비 폐업 89곳을 기록하였다(건강보험심사평가원 자료 보도 기준). 고령층은 초고령사회 진입(2024년 말 65세 이상 20% 초과) 속에 심뇌혈관질환 등 시간 민감성 중증 응급의 공간적 격차에 노출되어 있다. 본 프로젝트는 정책 질문을 '총량 확대'가 아닌 '공간 검토 우선순위의 도출'로 전환하였다. [자료와 대상] 대구광역시 150개 행정동을 대상으로, 응급 관련 기관은 총 25개소(Tier 1 6·Tier 2 13·Tier 3 6)로, 소아 모드는 보육시설 992개소(수요 대리지표)와 야간·휴일 소아진료기관(Tier 3) 6개소를, 어르신 모드는 행정동 중심점(수요)과 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2) 19개소를 기준 기관으로 사용하였다. 인구는 2026년 6월 기준월 주민등록 자료를 사용하였다. 화면 일부 수치는 검증용 예시 데이터이다(III장 데이터 상태표 참조). [방법] 국가 표준 좌표계(EPSG:5179) 정합, 반경 3km 버퍼(자가용 이동을 가정한 탐색적 기준)와 공간 결합에 의한 사각지대 필터링, 취약성 지수(VDI) 가중 K-Means 군집화와 엘보 기법을 적용하였다. K-Means는 최적 입지를 확정하는 도구가 아니라, 취약 수요의 공간 분포를 요약하여 후속 검토가 필요한 후보권을 생성하는 1차 탐색 도구로 사용하였다. [주요 결과] 실제로 이동시간 기반 취약성 지수(VDI) 산출 결과 위험 기준점(상위 25% 상대 기준, 13,261.43) 이상의 고위험 행정동이 150개 중 38개로 진단되었고, 민감도 분석으로 분류된 정책 후보 9개(소아 6·어르신 3)가 도출되었다. 시설 수 1~3개의 p-median·MCLP 조합 탐색에서는 소아 3개 조합 기준 30분 내 커버 인구 최대 113,713명(89.9%), 어르신 434,633명(82.1%)의 시나리오가 확인되었다. [모델 개선 과정] 분석 도중 초기 VDI(거리 × 취약인구)가 군위군 편입에 따른 거리 편차(최대 약 900배)에 지배되어 도심 밀집 사각지대를 '안전'으로 표기하는 왜곡 — 본 보고서가 '거리의 독재'라 명명한 현상 — 을 자체 진단하고, 거리에 자연로그를 취한 보정 산식(대표)과 Min-Max 정규화 산식(보조 비교 지표)으로 지수를 재설계한 뒤 파이프라인을 전면 재가동하였다. 나아가 K-Means 산출물을 '1차 후보'로 재정의하고, 군집 수·난수 시드·거리 상한·군위 처리 방식을 조합한 240개 시나리오 민감도 분석으로 조건 변화에도 반복 등장하는 안정 후보를 선별하였으며, 군위 후보는 별도 권역 후보로 분리하였다. 최종 단계에서는 민감도 분석으로 분류된 정책 후보 9개소를 카카오 실제 도로 이동시간(ETA) 행렬로 재평가하고, p-median·MCLP 두 목적함수로 시설 수 1~3개의 최적조합을 탐색하여 목적함수의 선택에 따라 우선 조합이 달라짐을 확인하였다(후보군 내 정확해이며 전역 최적해는 아님). [정책적 활용 가능성] 본 결과는 공식 데이터 검증, 주소 재지오코딩, 현장조사와 전문가 검토를 전제로, 지방정부의 후속 조사 우선순위 설정과 자원 배분 검토의 출발점으로 활용될 수 있다. [핵심 한계] 직선거리 기반 분석, 보육시설 대리지표, 실제 이송·임상 자료의 부재가 주요 한계이다. 요컨대 본 모델은 신규 의료기관의 최종 입지를 확정하는 모델이 아니라, 현재 확보된 공공데이터와 명시적인 정책 가정 아래 응급의료 접근성 개선 가능성이 높은 후보권을 선별하고 후속 현장조사와 전문가 검토의 우선순위를 제안하는 탐색적 의사결정 지원 프로토타입이다.

주제어: 소아 응급의료, 의료 사각지대, 공간적 형평성, 공동생산(co-production), 신공공서비스론, 사회적 자본, 증거기반 정책, GIS, 취약성 지수(VDI), K-Means 군집화

일러두기 — 작성 주제 및 도구 활용 고지

본 보고서와 기반 프로젝트 '대구 골든타임'은 필자가 기획·수행한 개인 프로젝트이며, 코드 및 문서 작성 과정에서 생성형 AI 도구와 공개 자료를 보조적으로 활용하였다. 문제의 정의, 분석 방법의 선택(안전망 버퍼 반경, 수요 대리지표, 군집 수 등), 결과의 검토·해석과 본 보고서의 최종 내용에 대한 책임은 전적으로 필자에게 있다. 본문에서 활용한 외부 통계·연구·행정자료는 모두 참고문헌에 출처를 밝혔으며, 화면 예시 등 일부 수치는 실자료 연계 전 단계의 검증용 예시 데이터임을 본문(III장 1절, VII장)에 명시하였다.

분석 결과의 기준시점과 갱신 가능성

본 보고서는 2026.07.18 검증본(공식 분석 릴리스 내부 식별자 2026-07-18-r2, 인구 기준월 2026.06)의 데이터와 본문에 명시한 분석 조건을 기록한 고정 스냅샷이며, 보고서의 수치와 결과는 이후에도 당시의 기록으로 보존된다. 따라서 본 보고서의 결과는 영구적으로 고정된 정책 결론이 아니라, 특정 시점의 데이터와 가정 아래에서 산출된 분석 결과로 읽어야 한다.

원천 데이터는 서로 다른 주기로 갱신된다. 병상과 진료·수용 정보는 수시로 달라지는 변동 정보이므로 본 보고서의 관련 수치를 현재의 이용 가능 상태로 해석해서는 안 되며, 주민등록인구는 월간 기준자료이고, 의료기관 기본정보와 행정구역 자료 역시 지정·개편에 따라 변경될 수 있다. 이에 따라 VDI·위험지역·정책 후보·도로 접근성·자원 보장 시나리오는 모두 기준시점이 있는 분석자료로 구분하여 읽는다.

구조적 원천 데이터가 변경되고 검증을 거치면 VDI와 위험지역은 재계산될 수 있으며, 정책 후보와 도로 접근성 결과는 별도의 재분석을 거쳐 갱신된다. 새로 산출된 결과는 검증을 마치기 전까지 기존 검증본을 대체하지 않는다. 아울러 본 보고서의 정책 후보는 확정 입지가 아니라, 향후 관계기관이 검토할 수 있는 정책 대안의 예시이자 현장조사와 전문가 검토를 위한 의사결정 지원 자료다. 결과가 시점에 따라 달라질 수 있다는 사실은 분석의 결합이 아니라, 새로운 데이터와 분석 조건을 반영하는 정상적인 재분석 과정이며, V장에서 제안한 연례 재분석의 제도화는 바로 이 갱신 경로를 행정 절차로 정착시키기 위한 것이다.

판본 정보 — 공식 분석 릴리스 2026-07-18-r2

본 판은 응급 관련 기관 25개소(Tier 1 권역응급의료센터 6·Tier 2 지역응급의료센터 13·Tier 3 야간·휴일 소아진료기관 6) 명단과 2026년 6월 기준월 주민등록인구를 반영해 파이프라인 전체를 재실행한 공식 분석 릴리스 2026-07-18-r2를 근거로 작성되었다. 본 판의 분석 수치는 릴리스 산출물(policy_release.json)에서 인용하였으며, 재실행 결과는 자동화 테스트(백엔드 분석 Pytest 33개, 프론트 Vitest 14개)와 정적 검사·프로덕션 빌드, 오프라인 정책 파이프라인 7단계 재실행, 산출물 무결성 해시(SHA-256) 검증을 통과하였다. 구 명단 기준의 이전 판본은 당시 기록(과거 스냅샷)으로 별도 보존된다.

목 차

I. 서론	4
1. 문제의 제기	
2. 프로젝트의 목적과 범위	
3. 보고서의 구성	
II. 이론적 배경과 선행연구	5
1. 응급의료 공급의 시장실패와 공적 개입의 정당성	
2. 신공공서비스론: '방향 잡기'에서 '봉사'로	
3. 공동생산(co-production)과 시민 개발 공익 서비스	
4. 의료 접근성과 공간적 형평성	
5. 증거기반 정책과 분석 논리의 공개	
6. 사회적 자본: 협치의 기반이자 산물	
III. 분석 설계와 방법	6
1. 분석 대상과 자료	
2. 분석 파이프라인: 4단계 공간분석 절차	
3. 타겟 모드 구조: 하나의 엔진, 두 개의 정책 과제	
4. 기초 지표의 재설계: '거리의 독재'와 VDI 듀얼 보정 모델	
5. 방법론적 선택의 정당화	
IV. 결과: 서비스 구현과 정책 도출	10
V. 정책 제언	14
VI. 논의: 사회과학적 의의	15
VII. 연구의 한계와 향후 과제	16
VIII. 결론	17
주석 — 용어 해설	18
참고문헌	18
부록. 분석 코드 구성 개요	19

I. 서론

1. 문제의 제기

최근 수년간 우리나라 소아 의료 공급 체계는 구조적 위축 국면에 있다. 건강보험심사평가원의 '의원 표시과목별 요양기관 개·폐업 현황'에 따르면, 소아청소년과 의원은 2024년 개업 69곳·폐업 64곳(전체 2,187곳)에서 2025년 개업 59곳·폐업 89곳(전체 2,156곳)으로, 한 해 사이 개업은 줄고 폐업은 크게 늘어 전체 기관 수가 31곳 감소하였다(메디컬투데이, 2026). 진료 개시 전부터 보호자가 대기 행렬을 이루는 이른바 '소아과 오픈런' 현상은 이러한 공급 위축이 일상의 풍경으로 나타난 결과이다(서울경제, 2023).

공급의 총량 부족 못지않게 심각한 것은 **공간적 배분의 불균형**이다. 야간·휴일에 경증·준응급 소아 환자를 수용하는 달빛어린이병원은 2020년 전국 17개소에서 2025년 10월 126개소로 크게 늘었으나, 그 절반에 가까운 56개소가 수도권에 집중되어 있고 경상북도는 2025년 7월까지 단 한 곳도 없었다(메디칼업저버, 2025). 대구광역시의 경우 2026년 3월 기준 달빛어린이병원은 동구·남구·북구·달성군 각 1곳과 달서구 2곳 등 6곳에 그치며(경북일보, 2026), 시 외곽과 신흥 주거지역의 보호자는 원거리 이동 또는 권역응급의료센터 쏠림이라는 차선의 선택을 강요받고 있다.

이 문제가 '골든타임'의 문제인 이유는 명확하다. 소아 환자는 성인에 비해 상태 악화 속도가 빠르고 증상 표현이 제한적이어서 초기 대응까지의 소요 시간이 예후를 좌우한다. 서울대병원·보라매병원·분당서울대병원 공동연구팀이 전국 22개 권역·지역응급의료센터 내원 18세 미만 환자 18,518명(2013~2017)을 분석하여 대한의학회지(JKMS)에 발표한 연구에 따르면, 최초 병원에서 수용되지 못하고 병원 간 이송된 소아 환자의 72시간 내 사망률은 직접 내원 환자의 1.9배(2.8% 대 1.5%), 30일 사망률은 1.6배(3.9% 대 1.9%)에 달하였다(테일리메디, 2023). 즉, 적정 시간 내 도달 가능한 의료기관의 **공간적 배치** 자체가 소아 환자의 생존 확률을 좌우하는 정책 변수인 것이다.

골든타임의 문제는 소아에게만 국한되지 않는다. 우리나라는 2024년 12월 65세 이상 주민등록 인구가 전체의 20%를 넘어서며 **초고령사회**에 진입하였다(행정안전부, 2024). 고령층 응급의 중심인 급성 심근경색·뇌졸중 등 심뇌혈관 질환과 낙상은 초기 대응 시간이 예후와 생존을 직접적으로 좌우하는 대표적인 시간 민감성 질환군으로, 소아와 마찬가지로 "집에서 대응 가능한 병원까지 얼마나 걸리는가"가 곧 생존 확률의 문제가 된다. 대구는 2023년 행정구역 개편으로 고령화율이 높은 농촌 지역(군위군)을 관내에 편입하여 이 격차가 한층 뚜렷해졌다. 요컨대 생애주기의 양 끝단 — 스스로 증상을 설명하지 못하는 소아와, 중증 응급 비중이 높은 고령층 — 이 모두 의료자원의 공간적 배치에 생존을 의존하는 취약 집단이며, 본 프로젝트가 소아 분석에서 출발해 고령층으로 분석을 확장한 이유가 여기에 있다. 덧붙이면 이 문제의식은 필자 개인의 생활 경험에 뿌리를 둔다. 필자가 거주하는 달성군 옥포읍은 응급의료 인프라가 취약한 지역으로, 심혈관 질환이 있는 가족에게 응급 상황이 발생할 경우 의지할 수 있는 응급실이 원거리에 제한적으로 존재한다는 현실적 불안이 본 분석의 직접적 출발점이 되었다 — 그리고 후술하듯(IV장·V장), 어르신 모드 분석은 실제로 달성군 남부 권역을 사각지대 거점 후보로 도출함으로써 이 체감을 데이터로 확인하였다.

2. 프로젝트의 목적과 범위

'대구 골든타임'은 이러한 문제의식에서 출발한 시민 개발 공익 웹서비스이다. 이 프로젝트는 대구광역시 수성구가 주최하고 (사)한국커리어혁신진흥원이 운영하는 실무 중심 교육과정 '실무형 AI·SW 인재 육성 Lab'(수성알파시티)의 교육생이 수행한 실무 프로젝트로 출발하였으며, 지역 SW 인재 양성 사업의 교육 산출물이 지역 공공문제 해결로 이어진 사례라는 점에서 그 자체로 분석의 대상이 된다(VI장 참조). 서비스는 두 개의 축(Track)으로 구성된다. 첫째, **Track 1 「진단」**은 대구광역시 150개 행정동 각각에 대하여 권역·대형 응급실, 일반 야간·휴일 응급실, 소아 응급(달빛어린이병원)까지의 접근성을 색상 지도(choropleth)¹⁾로 시각화하여, "이 동네 주민은 골든타임 안에 병원에 닿을 수 있는가"라는 질문에 시민 누구나 즉답을 얻을 수 있게 한다. 둘째, **Track 2 「골든 거버넌스」**는 공간분석과 기계학습을 결합한 파이프라인으로 소아 응급의료 사각지대를 정량적으로 식별하고, 취약성 지수(VDI)²⁾가중 군집 분석을 통해 신규 의료자원의 배치를 검토할 우선검토 후보권을 도출하여 지방정부의 자원 배분 검토를 지원한다. 파이프라인은 수요·공급의 정의만 교체하는 타겟 모드 구조로 설계되어, 소아(보육시설 수요 × 달빛어린이병원 공급)와 어르신(행정동 고령 수요 × 권역·지역응급의료센터 공급)이라는 서로 다른 두 정책 과제에 동일한 분석 엔진이 적용된다.

본 보고서의 목적은 두 층위로 구분된다. **프로젝트의 목적**은 두 취약 집단의 응급의료 접근성 사각지대를 공공데이터로 진단하고 정책 검토의 우선순위 후보를 도출하는 것이고, **보고서의 목적**은 그 설계와 결과, 그리고 분석 과정에서 발견한 지표 오류와 교정의 기록을 행정학·거버넌스 이론의 언어로 정리하여 후속 검증의 출발점을 제공하는 것이다. 여기서 본 분석의 위상을 분명히 해 둔다. 본 모델은 신규 의료기관의 최종 입지를 확정하는 모델이 아니다. 본 모델은 현재 확보된 공공데이터와 명시적인 정책 가정 아래, 응급의료 접근성 개선 가능성이 높은 후보권을 선별하고 후속 현장조사와 전문가 검토의 우선순위를 제안하는 **탐색적 의사결정 지원 프로토타입**이다.

본 보고서가 답하고자 하는 연구 질문은 다음 네 가지다. ① 대구의 소아·고령층 응급의료 접근성 사각지대는 어디에 분포하는가? ② 거리와 취약인구를 결합한 초기 취약성 지수(VDI)는 어떤 왜곡을 발생시키며, 어떻게 교정될 수 있는가? ③ 지표와 가중치 보정 후 정책 우선검토 후보는 어떻게 변화하며, 그 후보는 분석 조건의 변화에 얼마나 안정적인가? ④ 본 분석은 지방정부의 후속 조사와 자원 배분 검토에 어떻게 활용될 수 있는가?

3. 보고서의 구성

II 장에서는 시장실패론, 신공공서비스론, 공동생산론, 의료 접근성·형평성론, 증거기반 정책론의 다섯 가지 이론적 렌즈를 검토한다. III 장에서는 분석 대상·자료와 4단계 공간분석 파이프라인을 기술하고 방법론적 선택을 정당화한다. IV 장에서는 서비스 구현 결과를, V 장에서는 단기·중기·장기 정책 제언을 제시한다. VI 장에서 사회과학적 의의를 논의한 뒤, VII 장에서 한계와 향후 과제를 밝히고 VIII 장에서 결론을 맺는다.

II. 이론적 배경과 선행연구

1. 응급의료 공급의 시장실패와 공적 개입의 정당성

보건의료는 수요의 불확실성, 정보 비대칭, 외부효과로 인해 시장 기제만으로는 사회적으로 바람직한 수준의 공급이 이루어지기 어려운 가치재(merit goods)의 성격을 갖는다. 그중에서도 소아 진료는 ① 행위별 수가 낮아 수익성이 구조적으로 취약하고, ② 진료 결과에 대한 민원·소송 부담이 크며, ③ 저출산으로 수요 기반 자체가 축소되고 있어, 민간 공급자의 자발적 시장 진입을 기대하기 가장 어려운 영역으로 평가된다. 앞서 확인한 개·폐업 통계의 역전(2025년 개업 59곳 대 폐업 89곳)은 이러한 시장실패가 이미 진행 중임을 보여주는 경험적 증거이다(메디컬투데이, 2026). 고령층 응급의료 역시 구조는 동일하다. 인구가 적고 고령화율이 높은 농촌·외곽 지역일수록 중증 응급 대응 기관의 채산성이 낮아 공급이 약아지는데, 정작 시간 민감성 중증 응급의 수요는 바로 그 지역에서 높다 — 수요와 공급이 공간적으로 어긋나는 이 구조가 본 프로젝트가 겨냥하는 문제이다.

시장실패 영역에서 정부 개입의 정당성은 널리 인정되지만, 문제는 개입의 **방식**이다. 한정된 재정 여건에서 의료기관의 전면적 총량 확대는 현실적으로 곤란하며, 달빛어린이병원 확대 정책조차 지정 취소 기관이 매년 발생하고 야간 진료를 축소 운영하는 '반쪽짜리' 사례가 보고되는 등 공급 측 유인 설계만으로는 한계가 드러나고 있다(메디칼업저버, 2025). 따라서 정책의 초점은 "어디에, 얼마만큼의 자원을 우선 배치할 것인가"라는 **공간적 우선순위의 과학적 도출**로 이동할 필요가 있다. 본 프로젝트는 바로 이 지점, 즉 개입의 총량이 아니라 개입의 좌표를 최적화하는 문제에 답하고자 한다.

2. 신공공서비스론: '방향 잡기'에서 '봉사'로

Denhardt와 Denhardt(2000)의 신공공서비스론(New Public Service)은 행정의 역할을 신공공관리론이 상정한 '방향 잡기(steering)'가 아닌 '시민에 대한 봉사(serving)'로 재규정하고, 시민을 고객(customer)이 아닌 공공서비스의 주권자이자 공동 설계자로 위치시킨다. 이 관점에서 공공서비스의 설계는 행정 편의적 관할 구역이 아니라 시민의 실질 생활권에서 출발해야 한다.

본 프로젝트가 소아 의료 수요의 대리 지표로 주민등록 인구통계가 아닌 **유치원·어린이집의 공간 분포**를 채택한 것은 이러한 원칙의 방법론적 구현이다. 미취학 아동의 주간 생활권과 소아 응급 수요의 공간적 분포는 높은 상관을 가지므로, 보육시설 기반 수요 산정은 행정 통계만으로는 포착되지 않는 실질 생활권 기반의 수요를 반영한다. 또한 야간·휴일이라는 취약 시간대를 표적으로 삼는 것은 행정의 대응성(responsiveness)을 서비스 설계 단계에서부터 내장하는 것이라 할 수 있다.

3. 공동생산(co-production)과 시민 개발 공익 서비스

공동생산론은 공공서비스의 산출이 정부의 단독 생산물이 아니라 정부와 시민의 결합 노동에 의해 생산된다는 관점으로, Ostrom(1996)은 나이지리아와 브라질의 사례를 통해 시민의 투입이 공공서비스의 질과 지속가능성을 결정적으로 좌우함을 보였다. 국내에서도 권향원·윤영근(2020)은 '정책 공동생산'을 정책의 설계·집행·평가 단계에 시민이 실질적 생산자로 참여하는 문제해결 양식으로 개념화하고 사례를 유형화한 바 있다.

'대구 골든타임'의 현재 단계는 이 유형론에 비추면 **시민이 공공데이터를 재가공·분석하여 정책 대안을 제안하는 단계**에 해당하며, 완결된 공동생산 사례라기보다 **공동생산으로 발전할 가능성을 가진 시민주도형 분석**으로 규정하는 것이 정확하다. 정부가 데이터를 공개하고(공공데이터 개방), 시민이 이를 분석하여 정책 대안을 제안하며(본 프로젝트 — 현재 도달 지점), 행정이 이를 검토·검증하고 시범사업으로 연결하는(향후 단계) 흐름이 실제로 이어질 경우, 공공서비스 공급의 전(全) 주기에 걸친 순환형 협치(co-production cycle)로 발전할 수 있다. 분석 파이프라인의 소스코드와 판단 기준이 공개되어 있어, 시민 참여가 일회적 의견 제출이 아니라 **재현 가능한 분석 자산의 제안** 형태를 갖는다는 점이 기존 참여 방식과의 차이이다.

4. 의료 접근성과 공간적 형평성

Penchansky와 Thomas(1981)는 의료 접근성(access)을 가용성(availability), 접근성(accessibility), 편의성(accommodation), 부담가능성(affordability), 수용성(acceptability)의 다섯 차원으로 개념화하였다. 이 가운데 지리적 접근성은 GIS의 발전과 함께 계량화가 가장 활발히 진전된 차원으로, 공급 규모와 수요 인구, 이동 저항을 동시에 고려하는 2단계 유동권역법(2SFCA; Luo & Wang, 2003) 등이 표준적 방법으로 자리 잡았다. 국내에서도 응급실과 119 안전센터의 접근성을 결합한 GIS 기반 응급의료 취약지 분석과 진료과목별 공간적 불평등 분석이 축적되어 왔다.

형평성의 관점에서 본 프로젝트가 주목하는 것은 **수평적 형평성(horizontal equity)**, 즉 동등한 필요를 가진 사람은 거주지와 무관하게 동등한 접근 기회를 가져야 한다는 원칙이다. 어떤 병원의 서비스 권역(반경 3km)에도 속하지 못한 보육시설의 아동은 동일한 응급 상황에서 구조적으로 불리한 위치에 있으며, 이들에게 우선적으로 자원을 배분하는 것은 형평성 원칙의 직접적 적용이다. 요컨대 본 프로젝트의 '사각지대(blind spot)' 개념은 규범적 원칙(수평적 형평성)을 공간 연산(버퍼·공간 결합)으로 조작화(operationalize)한 것이다.

여기서 Penchansky와 Thomas의 개념 구분이 실질적 의미를 갖는다. 반경 3km 버퍼는 다섯 차원 중 지리적 **접근성(accessibility)**만을 측정하며, 병원이 가까이 있어도 전문의가 부족하거나 필수 장비(MRI·CT)가 없으면 실질적 대응이 불가능하다는 **가용성(availability)**의 문제는 포착하지 못한다. 다만 본 분석에서 실제로 가중치에 반영된 것은 거리 기반 VDI이며, 병원의 인력·장비 등 실질적 수용 역량(가용성)을 가중치 체계에 통합하는 것은 현재 파이프라인에는 구현되어 있지 않다 — 이는 접근성 이론이 구분하는 다차원 가운데 접근성 차원에 한정된 현재 분석의 한계이며, VII장에서 다시 짚는다.

5. 증거기반 정책과 분석 논리의 공개

증거기반 정책론(evidence-based policy)은 정책 결정이 이념·직관·정치적 고려가 아닌 체계적 증거에 기초해야 한다는 규범이며, Head(2008)는 이를 과학적 지식, 실무적 경험, 정치적 판단이라는 세 렌즈의 결합으로 정식화하였다. 자원 배분을 둘러싼 지역 간 경쟁이 첨예한 의료 인프라 정책에서 증거기반 접근의 실익은 특히 크다. "어느 지역이 취약한가"라는 인상적·민원 대응적 판단을 "어떤 시설이 어떤 병원의 3km 권역에도 속하지 않는가"라는 재현 가능하고 검증 가능한 공간 연산으로 대체하면, 배분 결정의 근거가 제3자에 의해 검증될 수 있기 때문이다.

나아가 본 프로젝트는 분석 결과뿐 아니라 분석 **논리** 자체를 GIS 대시보드로 공개한다. 정책 결정권자, 시의회, 시민이 동일한 화면에서 안전망 버퍼, 사각지대 시설, 우선검토 후보권의 도출 과정을 확인할 수 있다는 점에서, 이는 데이터 공개(open data)를 넘어선 분석 공개(open analysis)이며 증거기반 행정의 실질적 구현 사례에 해당한다.

6. 사회적 자본: 협치의 기반이자 산물

사회적 자본(social capital)은 신뢰, 호혜의 규범, 시민적 네트워크와 같이 구성원 간 협력을 촉진하여 공동의 문제 해결을 가능하게 하는 관계적 자산을 가리킨다. Coleman(1988)이 이를 인적 자본 형성의 사회구조적 조건으로 정식화한 이래, Putnam(1993)은 이탈리아 지방정부 비교 연구를 통해 시민적 전통과 사회적 자본이 두터운 지역일수록 제도의 성과가 높다는 것을 보임으로써, 사회적 자본을 거버넌스 성과의 핵심 설명 변수로 확립하였다.

사회적 자본은 공동생산의 **전제**이자 **산물**이라는 이중적 지위를 갖는다. 한편으로 시민이 행정의 데이터를 신뢰하고 행정이 시민의 분석을 진지하게 검토하는 상호 신뢰가 없다면 공동생산의 순환은 시작되지 않는다. 다른 한편으로 공동생산의 경험이 축적될수록 정부-시민 간 신뢰와 시민 상호 간 네트워크가 두터워져, 다음 협력의 거래비용이 낮아진다. 본 프로젝트에 비추어 보면, ① 분석 논리 전체를 공개하는 GIS 대시보드는 행정과 시민이 동일한 사실 기반을 공유하게 하는 신뢰 형성 기제이고, ② 재현 가능한 코드의 공개는 특정인의 전유물이 아닌 지역사회 공동의 문제 해결 자산을 남긴다는 점에서 일반화된 호혜성(generalized reciprocity)의 실천이며, ③ 지역 인재 양성 과정(수성알파시티)에서 형성되는 교육생-운영기관-지방정부 간의 관계망은 이러한 협력을 매개하는 연계형(bridging) 사회적 자본의 배양처라 할 수 있다. 요컨대 본 프로젝트가 산출하는 것은 지도와 좌표만이 아니라, 데이터에 기반해 협력하는 관계 그 자체이다.

III. 분석 설계와 방법

1. 분석 대상과 자료

분석의 공간적 범위는 대구광역시 전역(행정동 150곳)이다. 공급 측 자료로는 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2)와 달빛어린이병원(Tier 3)을 계층화한 병원 목록을 사용하며, 달빛어린이병원 정보는 대구광역시가 공식 지정·공표한 명단(대구광역시, 2026)과 개별 대조하여 반영하였다. 수요 측 자료는 분석 모드에 따라 달라진다. 소아 모드는 유치원·어린이집 992개소의 좌표를, 어르신 모드는 150개 행정동의 중심점에 VDI 및 고령 인구 밀도를 결합한 좌표를 수요 지점으로 사용한다. 서비스 화면(Track 1)에 표시되는 일부 거리·수치는 실자료 연계 전 단계의 검증용 예시 데이터이며, 이 사실은 서비스 내에 명시되어 있다(VII장 참조).

<표 1> 분석 자료의 구성

구분	자료	역할	출처
수요 (소아 모드)	유치원·어린이집 992개소 주소 목록	소아 응급 수요의 공간 대리지표(수요 지점)	공공데이터포털, 유치원알리미 등
수요 (어르신 모드)	행정동 150곳 중심점 + VDI·고령 인구 밀도	고령 응급 수요의 공간 단위(수요 지점)	통계지리정보, 자체 구축 취약도 데이터
공급	응급 관련 기관 25개소 — Tier 1 권역응급의료센터 6, Tier 2 지역응급의료센터 13, Tier 3 야간·휴일 소아진료기관(달빛어린이병원) 6. 소아 모드는 Tier 3(6개소), 어르신 모드는 Tier 1·2(19개소)를 기준 기관으로 사용	서비스 권역(안전망 버퍼)의 중심(공급 지점). 모드별로 해당 계층만 필터링	보건복지부·건강보험심사평가원 공개자료, 대구광역시 지정 명단
경계·취약도	행정동 경계(150개) 및 행정동별 취약성 지수 (GeoJSON)	Track 1 색상 지도의 공간 단위, K-Means 가중치 원천	통계청 통계지리정보, KOSIS 확정 인구자료·병원 좌표 기반 자체 산출 (spatial_analysis.py)

본 분석에 투입된 데이터는 확정 공공데이터, 자체 가공 데이터, 추정 데이터, 화면 검증용 예시 데이터가 혼재한다. 각 데이터가 어떤 상태에 있으며 그 위에서 산출된 결과를 어디까지 해석할 수 있는지를 <표 2>에 명시한다. 이 구분은 본 보고서 전체의 해석 한계를 규정하는 기준이 된다.

<표 2> 데이터 상태 및 활용 수준

데이터 항목	출처	현재 상태	검증 수준	본 분석에서의 활용	정책 해석 가능 여부	향후 보완 과제
행정동 경계(150개)	통계청 SGIS	확정 공공데이터	공식 자료	분석 공간 단위, 중심점 산출	가능	행정구역 개편 시 갱신
행정동 인구·취약인구	주민등록인구 통계 (월간)	확정 공공데이터 (기준월 2026.06)	공식 자료	VDI 산출의 인구 항, 최적화 목적함수의 인구 가중	가능 (기준월 명시)	월간 기준월 갱신 반영, 연령별 격차 단위 정밀화
달빛어린이병원 명단 (6개소)	대구광역시 공표 명단	확정 (공표 시점)	명단 개별 대조	소아 모드 공급 지점	가능 (시점 명시)	지장·취소 변동의 정기 반영
권역·지역응급의료센터 (19개소 — Tier 1 6·Tier 2 13)	복지부·심평원 공개자료	확정 (공표 시점)	공식 자료	어르신 모드 공급 지점	가능 (시점 명시)	지정 변동의 정기 반영
보육시설 주소(992개소)	공공데이터포털, 유치원알리미 등	확정 목록	목록 수준	소아 수요의 공간 대리지표	제한적 (대리지표)	시설 정원·야간 거주 수요와 결합
지오코딩 결과 좌표	Nominatim 변환(자체 가공)	자체 가공	부분 검증	수요 지점 좌표. 좌표 변환에 실패한 주소는 임의 좌표로 대체하지 않고 분석 대상에서 제외	불가 (재변환 전)	공식 주소 API 재지오코딩, 제외된 주소의 별도 보고(최우선 보완 과제)
도로 이동시간(ETA) 행렬	카카오 내비 경로 API(자체 수집)	수집 시점 스냅샷	자동 검증 (경로 수 일치)	후보 평가·ETA 기반 VDI. 150개 동 × (기관 25 + 후보 9) = 5,100개 경로 전량 확보(누락 0건)	제한적 (스냅샷)	시간대별 재수집, 구급차 통행 특성 반영
Track 1 화면 일부 거리·시간	자체 생성	검증용 예시 데이터	해당 없음	화면 구조 시연(서비스 내 명시 고지)	불가	실자료 연계 교체

주: '정책 해석 가능 여부'가 '불가'인 데이터 위에서 산출된 수치는 방법론의 작동을 보여주는 잠정값이며, 최종 정책 판단의 근거로 사용할 수 없다.

행정동 경계·좌표계에 관해서는, 저장된 행정동 분석 기준자료로서 행정동 150개와 좌표계를 검증하였다. 다만 원 제공기관과 정확한 개별 수집일은 원본 다운로드 기록을 통해 추가로 확인할 필요가 있다. 달빛어린이병원 명단과 권역·지역응급의료센터 명단 역시 공표 시점의 명단과 개별 대조하였으나, 각 기관 정보의 정확한 수집일자는 마찬가지로 원본 기록을 통한 추가 확인이 필요한 사항으로 남겨 둔다.

<그림 1> 데이터 상태 구분도 — 무엇 위에서 계산되고, 어디까지 해석할 수 있는가

확정 공공데이터 · 정책 해석 가능

- 행정동 경계(150개)
- 인구·취약인구(KOSIS)
- 달빛어린이병원 명단(6개소)
- 권역·지역응급의료센터(19개소)
- 보육시설 목록(992개소)

자체 가공·추정 데이터 · 구조 해석에 한정

- 지오코딩 좌표(실패 주소는 분석 제외)
- 도로 ETA 행렬(수집 시점 스냅샷)

예시·미작동 요소 · 정책 해석 불가

- Track 1 화면 일부 거리·시간(검증용 예시)

주: 상단 색 띠는 데이터 상태를 나타내며 <표 2>의 '정책 해석 가능 여부' 열과 대응한다. 황색·회색 항목 위에서 산출된 수치는 방법론의 작동을 보여주는 잠정값으로만 해석한다.

2. 분석 파이프라인: 4단계 공간분석 절차

Track 2 「골든 거버넌스」의 분석은 다음 네 단계(Phase A~D)로 구성되며, 전 과정이 Python(pandas, GeoPandas, scikit-learn)으로 구현되어 재실행 가능하다(부록 참조).

<그림 2> 전체 분석 파이프라인 흐름도 (● 확정 데이터 기반 · ● 추정·가공 데이터 개입)

① 공공데이터 수집

- 병원·보육시설·인구·경계

② 지오코딩·좌표 정합

- 주소→좌표, EPSG:5179 투영

③ 사각지대 필터링

- 3km 버퍼·공간 결합(직선거리 시나리오)

④ VDI 산출·로그 보정

- $\ln(1+거리) \times$ 취약인구, Min-Max 보조 지표

⑤ 가중 K-Means

- 후보권 생성(1차 탐색), 엘보 기법

⑥ 민감도 분석

- 240개 시나리오 → 안정·보류·별도 권역 구분

⑦ 도로 ETA·조합 탐색

- p-median·MCLP(분류된 후보군 한정)

⑧ 공개·검토 지원

- 대시보드 공개·정책 검토 지원

주: 각 단계의 점 색은 해당 단계에 개입하는 데이터의 상태(그림 1)를 요약한 것이다. ⑤의 산출물은 확정 입지가 아닌 정책 우선검토 후보권이다.

<표 3> 골든 거버넌스 파이프라인의 단계별 구성

단계	절차	기술적 구현	정책적 의미
Phase A 전처리	주소 지오코딩 ³⁾ 및 국가 표준 좌표계 정합	Nominatim(OpenStreetMap) 지오코딩 + 결과 캐싱, WGS84(EPSG:4326) → 평면직각좌표계(EPSG:5179, 미터 단위) ⁴⁾ 투영 변환	거리 왜곡 없는 정밀 연산 기반 확보, 시 GIS 행정시스템과의 호환성 담보
Phase B 공간 타깅팅	안전망 버퍼 생성 및 사각지대 필터링	공급 지정 기준 반경 3km 버퍼 ⁵⁾ 생성 후 공간 결합(spatial join) ⁶⁾ 으로 어떤 버퍼에도 속하지 않는 보육시설 선별. Haversine 대원거리 공식 ⁷⁾ 에 의한 독립 구현으로 교차 검증	'취약 지역'의 인상적 판단을 재현 가능한 공간 연산으로 대체
Phase C 군집 분석	사각지대 수요의 군집화 및 거점 도출(2단계 모델 발전)	① 기초 모델: 사각지대 시설 좌표에 K-Means ⁸⁾ 적용, 엘보 기법 ⁹⁾ 으로 K=2 도출 ② 파인튜닝: 행정동별 취약성 지수 (VDI)를 공간 결합으로 각 시설에 부여, 평균 정규화 후 표본 가중치(sample_weight) ¹⁰⁾ 로 주입 → 엘보 포인트가 K=4로 이동	단순 수요 밀집이 아닌 '의료적 취약도'가 거점을 끌어당기도록 설계 — 형평성 규범의 알고리즘 내장
Phase D 연계·공개	정량 지표 산출 및 대시보드 연동	거점별 배후 수요량(군집 소속 시설 수) 산출, JSON 규격으로 웹 프론트엔드에 전달, 버퍼·사각지대·거점의 중첩 렌더링	분석 논리의 공개를 통한 투명성·설득력 확보 (open analysis)

3. 타겟 모드 구조: 하나의 엔진, 두 개의 정책 과제

파이프라인은 거리 연산·버퍼·공간 결합·엘보 기법·가중 K-Means라는 분석 엔진을 공통 모듈로 두고, "누구의 수요를 어느 병원 계층이 감당하는가"라는 정의부만 모드별로 교체하는 구조(어댑터 방식)로 리팩토링되었다. 소아 모드는 보육시설 992개소를 수요로, 달빛어린이병원(Tier 3) 6개소를 공급으로 설정하며, 어르신 모드는 심뇌혈관·낙상 등 중증 응급 대응이 가능한 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2) 19개소를 공급으로, 행정동 150곳의 중심점(VDI·고령 인구 밀도 가중)을 수요로 설정한다.

이 구조의 방법론적 의의는 두 가지다. 첫째, 동일한 연산 규칙이 서로 다른 데이터에 적용되므로 두 모드의 결과 차이는 전적으로 **데이터의 차이**에서 나온다 — 분석자가 모드별로 다른 기준을 임의 적용했다는 의심을 구조적으로 차단한다. 둘째, 실제 실행 결과 후보권 수가 소아 K=4, 어르신 K=3으로 상이하게 분화되었는데(IV장), 이는 모델이 데이터의 공간 구조에 반응한다는 것을 보여주는 관찰이다. 다만 이 사실이 두 정책 과제의 동질성을 뜻하지는 않는다. 소아 모드는 보호자의 자가 이동이 가능한 야간·휴일 경증·준응급 진료 접근성의 문제이고 — 달빛어린이병원은 중증 소아응급센터가 아니다 — 어르신 모드는 119 이송 체계와 병원 수용 역량이 핵심인 중증 응급 대응의 문제다. 같은 엔진과 같은 3km 기준을 사용한 것은 기술적 재사용성과 비교 가능성을 위한 선택이며, 동일한 기준이 두 모드에서 갖는 정책적 의미가 같지 않다는 점은 결과 해석에서 일관되게 전제한다.

4. 기초 지표의 재설계: '거리의 독재'와 VDI 듀얼 보정 모델

가. 문제의식 — 스케일 왜곡이 만든 '거리의 독재(Distance Dictatorship)'

본 분석의 기초 지표인 행정동별 취약성 지수(VDI)는 당초 '**최근접 병원까지의 직선거리(km)** × **취약인구(65세 이상 + 0~9세)**'의 단순 곱으로 설계되었다. 이 산식은 자체 설계 지표인 만큼 그 구성 논리를 밝혀 둘 필요가 있다. 첫째, 위험을 **노출의 강도(거리로 인한 도달 지연)와 피해의 규모(그 지역에 노출되는 취약인구)의 곱**으로 정의한 것은 위험 평가(risk assessment)의 고전적 구조 — 위험 = 위해(hazard) × 노출(exposure) — 를 응급의료 접근성에 적용한 것이다. 둘째, 두 변수를 가산이 아닌 **승법으로 결합**한 것은, 병원이 인접하면(거리≈0) 인구가 많아도 접근성 위험이 성립하지 않고 취약인구가 부재하면 아무리 멀어도 피해가 성립하지 않는다는 — 두 조건이 동시에 충족되어야 위험이 발생한다는 — 상호작용(AND) 논리의 조작화이다. 가산 모델은 한 변수만으로도 지수가 상승하므로 이 논리에 부합하지 않는다. 셋째, 취약인구를 65세 이상과 0~9세로 정의한 것은 골든타입에 생존이 가장 민감하게 좌우되는 생애주기 양 끝단의 집단(I 장)을 반영한 것이다. 그러나 이렇게 논리를 갖춘 수식도, 2023년 행정구역 개편(군위군 편입)이라는 대구의 공간적 특수성과 만나 치명적인 통계적 왜곡을 낳았다. 도심의 최근접 병원 거리가 0.04km 수준인 반면 군위군 외곽은 35.6km에 달해 거리 변수의 편차가 최대 약 **900배**까지 벌어진 데 비해, 취약인구의 편차는 최대 **18배**에 그쳤기 때문이다. 두 변수를 그대로 곱하는 순간 지수는 사실상 거리의 단독 함수로 전락하였고, 외곽 지역의 VDI가 100,000점을 돌파하며 지도 전체의 위험도 임계 체계를 파괴하였다. 그 결과 수만 명이 밀집해 있으면서도 대형 종합병원이 없어 실제 구급 현장에서 '병상 수배 뺑뺑이'가 벌어지는 도심 내 핵심 사각지대(수천 점 수준)가 데이터 위에서 '안전지대'로 표기되는, 본 보고서가 '**거리의 독재**'라 명명한 현상이 발생하였다(이현석, 2026I).

이 현상의 사회과학적 함의는 가법적 않다. 형평성을 구현하기 위해 도입한 지표가 산식의 스케일 문제 하나로 인해 또 다른 형태의 공간적 불평등 — 외곽의 절대 거리가 도심의 밀집 위험을 침묵시키는 — 을 재생산한 것이다. 지표는 규범의 조작화(II 장 4절)인 동시에, 잘못 조작화된 규범은 그 자체로 배분 왜곡의 원천이 된다.

나. VDI 듀얼 보정 모델(Dual Recalibration)의 설계

이러한 통계적 왜곡을 교정하고 응급의학적 당위성을 회복하기 위해, 두 가지 수학적 보정 모델을 동시에 도입하고 공간분석 모듈(spatial_analysis.py)을 전면 재가동하였다. 첫째, 대표 지표로 채택한 **비선형 로그 보정 모델¹¹⁾**($VDI = \ln(1 + \text{최근접 병원 거리}) \times \text{취약인구}$)이다. 응급 상황에서 병원 거리가 1km에서 5km로 멀어질 때의 위험도 증가는 치명적이지만, 이미 골든타입을 상실한 31km와 35km 사이의 체감 위험도 차이는 한계 체감(diminishing returns)을 보인다는 판단을 산식에 반영한 것으로 — 이 판단은 임상 자료로 검증된 사실이 아니라, 원거리 극단값의 지배력을 완화하기 위해 채택한 명시적 정책 가정이다 —, 거리 변수에 자연로그를 취함으로써 극한의 아웃라이어가 지수 전체를 파괴하지 못하도록 점근적으로 평탄화(asymptotic flattening)하였다. 주목할 것은 이 보정이 원 산식의 설계 논리 — 위험은 거리의 단조 증가 함수이며 강도와 규모의 승법 결합이라는 구조 — 를 폐기하는 것이 아니라, 증가의 **형태**만 선형에서 로그로 교체한다는 점이다. 즉 지표의 이론적 정당성은 유지된 채 스케일 결함만 교정된다. 둘째, 보조·검증 지표인 **완전 균형**

모델이다. 거리와 인구 배열을 각각 Min-Max 정규화¹²⁾로 0과 1 사이에 압축하여 단위를 완전히 소거한 뒤 5:5의 동일 가중으로 결합(0~100점)한 교과서적 지표로서, 로그 보정 모델과 다른 산식 가정 위에서 결과를 비교하는 대체 산식 기반 민감도 점검 지표의 역할을 수행한다.

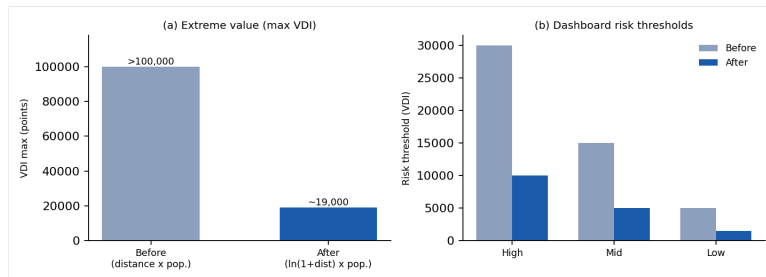
다. 보정의 타당성 검증

보정의 효과는 세 측면에서 점검되었다(이현석, 2026l). 첫째, **분포 측면**에서 기존 100,000점을 상회하던 극단값이 약 19,000점 수준으로 안정화되었고(평균 4,595점), 거리 극단값이 지수 전체를 지배하던 현상이 완화되었다(변수별 기여도의 정량 수치는 공식 데이터 재산출 시 함께 보고한다). 둘째, **현실 정합성에 대한 탐색적 점검**으로서, 보정 지수를 지도에 시각화하자 산간 외곽뿐 아니라 인구 밀도는 높으나 대형 종합병원이 부재한 도심 내 사각지대(수성구·달서구 일부 외곽 택지지구)가 고위험으로 점등되기 시작하였다. 이는 119 구급 현장에서 병상 수배의 어려움이 보고되어 온 인구 과밀 지역의 체감과 방향이 일치하나, 실제 이송·수배 자료와의 대조는 수행되지 않았으므로 탐색적 관찰에 머문다. 셋째, **재현성 측면**에서 지수는 국가통계포털(KOSIS)의 확정 인구자료와 병원 좌표로부터 결정론적(deterministic)으로 산출되므로 누가 언제 재실행해도 동일한 결과가 재현된다. 아울러 당시 대시보드의 위험도 판정 임계치를 새 지수 분포에 맞춰 조정하였다(기존 30,000·15,000·5,000 → 10,000·5,000·1,500 — 이는 2세대 거리 기반 지수 당시의 프로토타입 화면 기준으로, 현재 서비스에서는 사용하지 않는다). 행동동 상해 패널에는 대표 지표(로그 보정 VDI)와 Min-Max 정규화 지수(0~100)를 병렬 표출하여 서로 다른 산식 가정의 결과를 비교할 수 있게 하였다. 재실제 전후의 변화를 요약하면 <표 4>와 같다. 이상의 수치는 거리 기반 지수(2세대)의 당시 산출 기록이며, 현행 릴리스의 대표 지수는 실도로 이동시간(ETA) 기반 지수(3세대)로 전환되었다 — 현행 분포와 위험 기준은 IV장 2절과 그림 5에 제시한다.

<표 4> VDI 재설계 전후 비교 — 기존 모델 대 로그 보정 모델

항목	기존 모델 (재설계 전)	로그 보정 모델 (재설계 후)
산식	최근접 병원 직선거리(km) × 취약인구	$\ln(1 + \text{최근접 병원 거리}) \times \text{취약인구}$
변수 기여 구조	거리 편차(최대 900배)가 인구 편차(최대 18배)를 압도 — 사실상 거리의 단독 함수화	거리 극단값의 지배력이 완화됨 (정량적 기여도 수치는 공식 재산출 시 보고 예정)
지수 분포	외곽(군위군) VDI가 100,000점 돌파 , 지도 전체의 임계 체계 파괴	극단값 약 19,000점 으로 안정화(약 1/5 수준), 전체 평균 4,595점
도심 밀집 사각지대	수천~13,000점 수준으로 상대 왜소화 → 히트맵상 '안전지대'로 은폐	상대 순위 회복 — 수성구·달서구 외곽 택지지구가 고위험으로 점등 (현실 정합성은 탐색적 점검 수준, 이송 자료 대조 미수행)
대시보드 위험도 임계치	30,000 / 15,000 / 5,000	10,000 / 5,000 / 1,500 (2세대 프로토타입 화면 기준 — 현재 서비스 미사용)
K-Means 파급 효과	군집 중심이 외곽 극단값에 종속(과적합 경향) — 군위 등 외곽 편향 배치	도심·외곽을 아우르는 균형 거점 도출(IV장 2절)

주: 수치는 VDI 종합 검증 및 개선 보고서의 산출값 기준이며, 보조 지표인 Min-Max 정규화 모델(0~100점)은 별도 스케일이므로 비교에서 제외함. 자료: 이현석(2026l).



<그림 3> VDI 로그 보정 전후 요약 지표 비교(거리 기반 2세대 지수의 당시 산출 기록). (a) 극단값(최댓값)이 100,000점 상회에서 약 19,000점으로 안정화되었고(보정 후 전체 평균 4,595점), (b) 대시보드 위험 판정 임계치를 새 분포에 맞춰 조정하였다. 본 그림은 산출 기록으로 검증된 요약 수치만을 사용하였으며, 행동동별 전체 분포 곡선과 위험 순위 변화표는 공식 데이터 재산출과 함께 제시할 예정이다.

5. 방법론적 선택의 정당화

가. 반경 3km 기준: 탐색적 근거리 접근 시나리오

3km는 야간에 보호자가 자가 차량으로 이동하는 상황을 가정한 **탐색적 기준**이다. 실제 소요 시간은 교통수단·시간대·도로 환경에 따라 달라지므로 '약 10분'과 같은 환산을 단정할 수 없으며, 본 보고서는 3km를 '엄격한 근거리 접근 시나리오'로 규정한다. 유의할 점은 반경과 사각지대 규모의 관계다. 반경이 작아지면 병원의 커버 영역이 줄어 사각지대는 일반적으로 **더 많이** 검출되고, 반경이 커지면 줄어든다. 따라서 3km 결과를 사각지대의 '하한선'으로 단정할 수 없다. 올바른 해석 틀은 복수 시나리오의 병행이다 — 3km(엄격한 근거리 시나리오), 5km(중간 시나리오), 10km 또는 이동시간 기준(완화 시나리오)을 함께 산출하고, **여러 기준에서 반복적으로 사각지대로 판정되는 지역을 강건한 핵심 사각지대로 해석**하는 것이다. 본 보고서의 사각지대 산출은 3km 직선거리 시나리오에 기반한다. 복수 시나리오 비교는 향후 과제이며, 실제 도로 이동시간(ETA)은 후속 단계인 안정 후보 평가와 VDI 산출에 도입되었다(IV장 2절) — 다만 사각지대 필터링 단계 자체의 이동시간 기준 교체는 남은 과제다(VII장). 그림에도 3km를 1차 기준으로 채택한 정책적 이유는 두 가지다. 야간 소아 응급이라는 시간 민감 상황에서 근거리 접근성이 갖는 규범적 중요성, 그리고 임계값을 명시적으로 공개하여 제3자가 다른 값으로 재실행할 수 있게 하는 검증가능성이다. 아울러 동일한 3km가 소아 모드(보호자 자가 이동)와 어르신 모드(구급 이송 중심)에서 갖는 정책적 의미는 동일하지 않으며, 어르신 모드 임계값의 재검토 필요성은 VII장에 명시한다.

나. 이중 구현에 의한 강건성 확보

거리 연산은 두 가지 독립적 방식으로 구현되었다. 하나는 GeoPandas 기반으로 EPSG:5179 투영 좌표계에서 버퍼-공간 결합을 수행하는 방식이고, 다른 하나는 외부 공간 라이브러리 의존 없이 위경도 좌표에 Haversine 대원거리 공식을 적용하여 최근접 병원 거리를 직접 계산하는 방식이다. 서로 다른 기하 가정을 가진 두 구현이 동일한 사각지대 집합을 산출하는지 교차 확인함으로써 결과의 강건성(robustness)을 높였다.

다. 군집 수의 결정: 엘보 기법과 VDI 가중의 상호작용

군집 수 K 는 임의로 지정하지 않고 **엘보(elbow) 기법**으로 도출하였다(이현석, 2026e). 주목할 것은 가중치 설계에 따라 최적 K 자체가 달라졌다는 점이다. 사각지대 시설의 밀집도만을 기준으로 한 기초 모델에서는 $K=2$ 가 최적으로 판별되었으나, 이 모델은 수요가 많은 곳으로만 중심점이 쏠려 가장 소외된 외곽 지역이 수요 시설 수가 적다는 이유로 중심측에서 배제되는 한계(중력 손실, gravity loss)를 드러냈다. 이에 행정동별 취약성 지수(VDI)를 평균 정규화하여 표본 가중치로 주입하자 엘보 포인트가 $K=4$ 로 이동하였고, 거점이 더 세밀하고 포용적으로 분할되었다. K-Means의 중심점은 **취약도 가중 수요지점에 대한 제공거리 합을 최소화하는 공간적 중심**이다. 이는 실제 도로 이동거리나 총 이동시간을 최소화하는 p-median 계열 입지 모형과 목적함수가 다르며(후자는 IV 장 2절의 후속 단계에서 안정 후보 평가에 별도로 적용되었다), "평균 이동 부담을 최소화하는 지점"이라는 통상의 서술은 이 제공거리 기준의 근사적 요약으로만 이해해야 한다. 다만 K-Means는 실제 도로 이동시간, 부지 확보 가능성, 토지이용 규제, 신설 비용, 병원별 수용 한계, 의료진 확보 가능성, 법적·도시계획상 입지 가능성을 고려하지 않는다. 따라서 그 중심점은 '최적 입지'가 아니라, **취약 수요의 공간 분포를 요약하여 후속 검토가 필요한 후보권을 생성하는 1차 탐색 도구의 산출물**로 해석하며, 본 보고서 전체에서 이 정의를 일관되게 적용한다.

라. 재현가능성의 설계

지오코딩 결과는 캐시 파일로 저장되어 동일 입력에 대해 동일 좌표를 보장하며, K-Means의 난수 시드가 고정되어 있어 제3자가 파이프라인을 재실행하면 동일한 거점이 도출된다. 서비스·분석 계층 역시 릴리스 기준으로 자동화된 테스트(벤치마크·분석 Pytest 33개, 프론트 Vitest 14개)와 정적 검사(ESLint), 프로덕션 빌드(TypeScript·Vite), 오프라인 정책 파이프라인 7단계 전체 재실행, 산출물 무결성 해시(SHA-256) 대조를 통과하였다. 다만 정책 분석 화면의 지도 상호작용에 대한 실제 브라우저 환경에서의 확인은 본 판에서 별도로 검증되지 않았으므로, 로컬 화면에 대한 수동 시각 점검이 별도로 필요하다. 이는 의료기관 개·폐업 변동을 반영한 연례 재분석(V 장)의 기술적 전제이자, 증거기반 정책의 요건인 검증가능성의 구현이다.

IV. 결과: 서비스 구현과 정책 도출

1. Track 1 「진단」: 행정동 단위 접근성 시각화

Track 1은 대구 150개 행정동을 응급의료 접근성에 따라 색상으로 구분한 지도 서비스이다. 색이 진할수록 응급실이 멀거나 병상이 부족한 주의 지역이며, 이용자는 ① 내 동네 찾기 → ② 색으로 확인 → ③ 클릭하여 상세 확인의 세 단계로 정보에 도달한다. 행정동 클릭 시 권역·대형 응급실, 일반 야간·휴일 응급실, 소아 응급(달빛어린이병원)까지의 거리가 계층별로 병렬 표시된다. 예컨대 기획 화면 기준 달성군 구지면은 대형 응급실까지 18.0km, 일반 응급실까지 11.5km, 소아 응급까지 32.5km로, 소아 응급 공백 지역의 전형적 사례에 해당한다(수치는 검증용 예시 데이터).

기존 병원 지도가 위치와 진료과목만을 표시하는 것과 달리, Track 1은 ① 중증·일반·소아 응급의 계층 구분, ② 거리·시간·병상의 종합 표시, ③ 동네 간 취약도 비교라는 세 가지 정보를 추가로 제공한다. 이는 개별 시민의 의사결정(이사, 야간 대비)뿐 아니라 행정의 우선순위 논의에 공통의 사실 기반을 제공하는 것을 목표로 한다.

서비스는 현재 진단 지도를 넘어 **지능형 응급의료 관제 대시보드**로 발전 중이다(이현석, 2026k). 시민(구급대원·보호자) 모드는 직선거리가 아닌 실시간 교통 반영 도착 예정 시간(ETA) 기준으로 병원 목록을 자동 정렬하고 수용 불가 병원을 시각적으로 구분하며, 정책 관리자 모드는 병원별 전문의 수·장비 보유 등 수용 역량 정보를 관제 화면에 표출한다. 국민 생명과 직결된 서비스라는 성격을 고려해 실시간성이 요구되는 항목에서는 임의로 꾸며낸 값의 상시 노출을 지양하고, 공공 API 통신 불안정에 대비한 사실 기반 오프라인 폴백을 기본 아키텍처로 채택한 점도 특기할 만하다(화면별 실자료·예시 데이터 구분은 IV 장 4절 참조). VDI 듀얼 보정(III 장 4절) 이후에는 행정동 상세 패널에 대표 지표(로그 보정 VDI)와 Min-Max 정규화 지수(0~100)가 병렬 표출되고, 선택 행정동의 VDI·최근접 거리·취약인구가 대구시 평균 대비 상대 비율로 함께 제시되어, 정책 입안자가 단일 점수가 아닌 다각도의 근거로 위험도를 판단할 수 있도록 개선되었다.

2. Track 2 「골든 거버넌스」: 모델의 발전 과정

모델은 다섯 단계를 거쳐 발전하였으며, 그 과정 전체가 내부 문서로 기록되어 있다(이현석, 2026e; 2026i; 2026j; 2026n). 초기 구축 단계(달빛어린이병원 4개소, 초기 지오코딩 데이터 기준)에서는 보육시설 992개소 중 107개소가 사각지대로 도출되었고, 수요 밀집도만 반영한 기초 모델은 엘보 기법상 $K=2$ — 동북부(배후 수요 73개소)와 서남부(34개소) — 를 제시하였다. 그러나 이 모델은 수요가 많은 곳으로 중심점이 쏠려, 가장 소외된 외곽 지역이 수요 시설 수가 적다는 이유로 중심측에서 배제되는 한계(중력 손실)를 드러냈다.

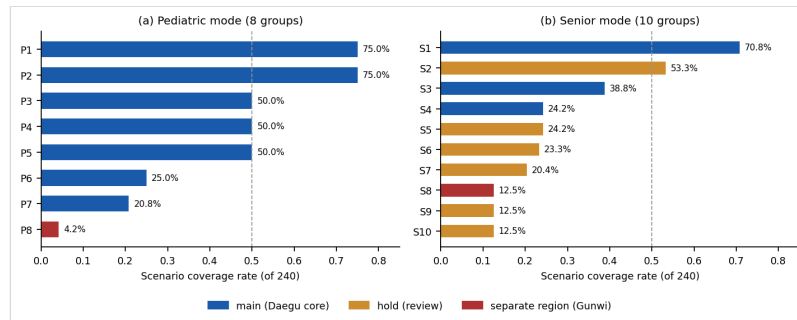
이에 행정동별 취약성 지수(VDI)를 표본 가중치로 주입하자 엘보 포인트가 $K=4$ 로 이동하며 거점이 세분화되었고, 특히 수요가 3개소에 불과한 군위 방면이 지리적 고립에 따른 높은 취약도만으로 독자 거점으로 부상하였다. 효율성 논리로는 결코 거점이 될 수 없는 지역이 형평성 가중으로 포착된 이 결과는, II 장의 수평적 형평성 원칙이 알고리즘 수준에서 실제로 작동함을 보여주는 경험적 증거이다. 이후 공급 명단을 최신 지정 현황(달빛어린이병원 6개소)으로 갱신하고 수요 좌표를 정비한 뒤, 파이프라인을 타겟 모드 구조(III 장 3절)로 리팩토링하여 소아·어르신 두 모드를 동시 가동하였다.

발전의 세 번째 단계는 가중치 체계가 아니라 그 **원천 데이터**를 겨냥하였다(발전의 네 번째 단계는 본 절 말미에 후술한다). III 장 4절에서 기술한 대로 초기 VDI 산식의 스케일 왜곡이 진단되자, 로그 보정을 거친 새 VDI를 주입하여 소아·어르신 두 모드의 K-Means 파이프라인 전체를 전면 재가동한 것이다(ai-model/run_integrated_policy_pipeline.py). 그 효과는 근본적이었다. 왜곡된 10만 점대 VDI가 가중치로 주입되던 단계에서 모델은 군위군 등 외곽 지역으로 군집 중심이 과도하게 기울리는 편향 — 소수의 극단값이 해 전체를 좌우하는 일종의 과적합(over-fitting) — 을 안고 있었다. 그러나 극단값이 1.9만 점 수준으로 억제된 새 데이터를 주입하자, 수성구·달서구 등 **인구 과밀형 도심 사각지대**가 비로소 온전한 크기의 가중치로 군집 형성에 참여하며 새로운

우선검토 후보로 부상하였고, 도심 후보의 우선순위가 데이터로 뒷받침되었다. 요컨대 형평성을 위해 주입한 가중치조차 그 산식이 왜곡되어 있으면 또 다른 편향의 통로가 된다는 것, 그리고 기초 지표에 대한 수학적 보정 없이 원시 데이터(raw data)를 공간 군집 분석에 맹목적으로 주입할 경우 '병상 수배 뺑뺑이'로 상징되는 도심 핵심 사각지대를 알고리즘 스스로 은폐할 수 있다는 것이 파이프라인 재가동 과정에서 관찰되었다. 재가동 결과는 갱신된 우선순위 산출물로 정책 대시보드에 반영되었으며, 이로써 본 분석은 외곽 소외 지역(군위군)의 절대적 공백을 커버함과 동시에 도심 내 인구 밀집형 사각지대를 함께 식별하는, 도심과 외곽을 아우르는 균형 잡힌 후보 구성에 도달하였다.

발전의 네 번째 단계는 산식이나 가중치가 아니라 **산출물의 인식론적 지위**를 겨냥하였다(이현석, 2026n). 지표와 가중치를 아무리 정교화해도, K-Means의 중심점을 '최적 입지의 확정'으로 읽는 순간 모델은 그 능력 이상의 권위를 갖게 된다. 이에 K-Means를 **최종 결정 모델이 아닌 '1차 후보 생성기'로 재정의**하고, 도출된 각 후보에 검증 가능한 근거를 부착하였다. 구체적으로, 후보마다 후보 신설 전후의 행정동별 최근접 접근거리 변화(접근성 개선량: $\text{gain} = \text{before} - \text{after}$)를 취약인구 가중 평균으로 산출하고, 개선 수혜 행정동 목록·커버 취약인구·최근접 기존 병원을 추적 파일(candidate trace)로 기록하여, 화면의 모든 후보 마커가 "왜 이 후보인가"에 데이터로 답할 수 있게 하였다. 후보 요약용 점수는 '평균 개선량 $\times \log(1 + \text{커버 취약인구})$ '로 설계하였는데, 인구를 로그로 눌러 반영한 것은 III장 4절에서 확립한 스케일 통제 원칙 — 큰 변수가 지수를 지배하지 못하게 한다 — 을 새 지표 설계에 재적용한 것이다.

나아가 후보의 강건성을 체계적으로 시험하였다. 좌표계를 EPSG:5179 투영좌표로 교체한 재실험에서 후보 좌표의 이동이 제한적임을 확인한 뒤(재계산 기준 최대 0.9km 미만), 군집 수 K(2~5), 난수 시드(5종), 거리 상한(4종), 군위 처리 방식(포함·별도 권역·제외)을 조합한 **240개 시나리오의 민감도 분석**을 수행하여, 조건을 바꿔도 반복 등장하는 후보권을 '안정 후보'로 선별하였다. 그 결과 소아 모드는 두 개의 메인 후보권이 시나리오의 75%에서 반복 등장하였고, 어르신 모드는 동부권 후보(70.8%)가 가장 안정적이었으며, 군위 후보는 반복 출현율이 낮아(소아 4.2%, 어르신 12.5%) 삭제하는 대신 **대구 본시가지와 의료 접근 구조가 다른 '별도 권역 후보'로 분리**하였다 — 극단값을 제거가 아닌 분류로 다루는 이 처리 역시 III장 4절의 원칙과 일관된다. 이 단계에서 모델 기능 강화의 동결(freeze)이 선언되었고 이후 작업은 검증·문서화·표현의 정확화로 한정하기로 하였다 — 단, 남겨 두었던 도로망 과제 가운데 후보 평가 단계의 실측 보완이 마지막 확장으로 뒤따랐다(다섯 번째 단계, 후술). 요컨대 본 분석의 최종 산출물은 '최적 입지의 확정'이 아니라, **근거와 안정성 등급이 부착된 정책 우선검토후보의 집합**이며, 이는 분석 도구가 정책 결정을 대체하는 것이 아니라 보조한다는 증거기반 정책론(II장 5절)의 위상 규정을 모델 구조 자체에 새긴 것이다.



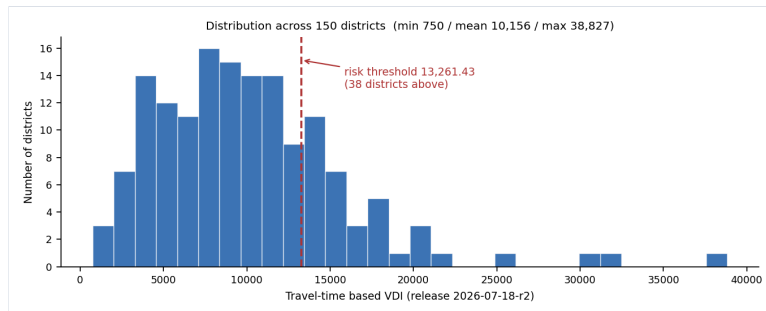
<그림 4> 240개 시나리오 민감도 분석 — 후보권별 반복 출현율. 군집 수(K 2~5)·난수 시드(5종)·거리 상한(4종)·군위 처리(3종)를 조합한 240개 시나리오에서 각 후보권(3km 근접 그룹)이 등장한 비율. 소아 메인 2개 후보권(P1·P2)이 75%로 가장 안정적이고, 어르신은 동부권(S1, 70.8%)이 최고이며, 군위 후보(P8 4.2%·S8 12.5%)는 반복률이 낮아 별도 권역 후보로 분류된다. 라벨 P·S는 소아·어르신 모드의 후보권 식별자이다. 자료: 후보 민감도 분석 산출물(이현석, 2026n).

발전의 다섯 번째 단계는 직선거리의 한계를 후보 평가 단계에서 실측으로 보완한 **통합 정책 입지 모델**이다(이현석, 2026p). 민감도 분석을 통해 안정·보류·별도 권역으로 분류된 정책 후보 9개소(소아 6·어르신 3)를 대상으로, 150개 행정동과 응급 관련 기관 25개소(Tier 1 6·Tier 2 13·Tier 3 6) 및 정책 후보 9개 사이의 **실제 도로 이동시간(ETA) 행렬**을 카카오 내비게이션 경로 기준으로 구축하고 — $150 \times (25 + 9) = 5,100$ 개 **경로 전량 확보, 누락 0건**(경로 불가 시 추정치로 대체하지 않는 규칙은 유지) — 취약 행정동 VDI를 도로 ETA 기반 지수로 전환하였다(이현석, 2026q). 전환된 현행 지수의 분포는 최솟값 약 750점·평균 약 10,156점·최댓값 약 38,828점이며, 행정동 취약성 지수 상위 25%에 해당하는 상대 위험 기준점(13,261.43) 이상의 고위험 행정동은 150개 중 38개로 진단된다(그림 5). 그 위에서 시설 수 $p=1\sim 3$ 의 모든 후보 조합을 **p-median**(취약인구 가중 평균 ETA 최소화)과 **MCLP**(15분·30분 내 커버 인구 최대화)의 두 목적함수로 정확 탐색하여, 소아(0~9세 126,483명)·고령층(65세 이상 529,419명, 2026년 6월 기준월)의 인구 가중을 분리한 조합 탐색 결과를 산출하였다(<표 8>). 주목할 것은 **목적함수가 다르면 최적조합도 달라진다는 점**이다. 평균 이동시간을 줄이는 조합과 제한시간 내 인구를 늘리는 조합 중 어느 하나를 절대적 정답으로 제시하지 않으며, 이는 어떤 가치 기준을 택하느냐가 결과를 바꾼다는 본 보고서의 일관된 논지가 목적함수 수준에서 재확인된 것이다. 다만 이 결과는 K-Means 안정 후보군 내부의 정확 최적조합이지 대구 전역 모든 좌표를 탐색한 전역 최적해가 아니며, 도로 ETA는 수집 시점의 스냅샷으로 시간대별 교통 변동과 급급차 우선 통행을 반영하지 않는다. 경로 캐시(SHA-256 키)와 체크포인트, 오프라인 재현 명령이 함께 구현되어 재현성은 유지되며, 이 확장을 끝으로 모델은 검증·문서화 중심의 유지보수 단계로 전환되었다.

<표 8> 실제 도로 ETA 기반 p-median-MCLP 조합 탐색 결과 (2026.07.18 검증본)

모드	시설 수 p	탐색 조합 수	p-median 선택 조합 (취약인구 가중 평균 ETA)	MCLP 15분 선택 조합 (15분 내 커버율)	MCLP 30분 선택 조합 (30분 내 커버율)
소아	1	6	후보 1 (14.41분)	후보 1 (13.7%)	후보 1 (71.0% · 89,846명)
	2	15	후보 1·4 (13.42분)	후보 1·3 (26.1%)	후보 1·3 (82.4% · 104,210명)
	3	20	후보 1·3·4 (12.97분)	후보 1·3·4 (36.3%)	후보 1·2·3 (89.9% · 113,713명)
어르신	1	3	후보 1 (11.51분)	후보 1 (10.0%)	후보 1 (49.8% · 263,705명)
	2	3	후보 1·3 (11.24분)	후보 1·2 (11.4%)	후보 1·2 (80.7% · 427,465명)
	3	1	후보 1·2·3 (11.15분)	후보 1·2·3 (11.6%)	후보 1·2·3 (82.1% · 434,633명)

주: 후보 번호는 릴리스의 후보 식별자(소아 1~6, 어르신 1~3)이며, 괄호 안은 각 목적함수의 성과값이다. 소아 p=2·3과 어르신 p=2에서 p-median과 MCLP의 선택 조합이 서로 다르다 — 목적함수의 선택이 다를 때문이다. 본 결과는 분류된 후보군 내부의 정확도로 대구 전역의 전역 최적해가 아니고, ETA는 수집 시점의 분석용 일반 차량 이동시간으로서 구급차 운행시간·교통상황·실제 이송 가능성·병원 수용 가능성을 보장하지 않는다. 자료: 이현석(2026q) policy_release.json.



<그림 5> 현행 실도로 이동시간 기반 VDI의 행정동 분포(2026.07.18 검증본). 150개 행정동의 지수 분포와 위험 기준점(상위 25% 상대 기준, 13,261.43, 점선)을 표시하였다. 기준점 이상의 고위험 행정동은 38개다. 지수는 2026년 6월 기준월 인구와 25개소 기관 명단, 5,100개 실도로 경로 위에서 산출되었다. 자료: policy_release.json(vulnerability).

3. 최신 산출 결과: 소아 모드와 어르신 모드 (2026.07.18 검증본)

결과를 제시하기에 앞서 산출물의 지위를 분명히 한다. 이하의 거점은 **병원 시설의 확정 입지가 아니라, 접근성 개선 근거가 부착된 정책 우선검토후보**이며 (2절 네 번째 단계 참조), 본 모델은 최종 입지 확정 모델이 아니라 취약인구와 접근성 개선량을 기준으로 정책 검토 후보를 선별하는 **1차 의사결정 지원 모델**이다. 민감도 분석에서 반복 등장한 안정 후보와 조건에 민감한 보류 후보, 별도 권역 후보(군위)는 구분하여 해석하여야 한다.

소아 모드의 기준 기관은 야간·휴일 소아진료기관(Tier 3) 6개소로, 기준 기관만 있을 때 0~9세 취약인구 가중 평균 ETA는 **15.93분**이다. 민감도 분석에서 분류·승계된 소아 후보는 6개(대구 본시가 지 5·별도 권역 1)이며, 후보를 1개씩 추가했을 때의 접근성 개선 폭은 <표 5>와 같다. 앞선 발전 과정(2절)의 사각지대 필터링·K-Means 단계 산출(107→414개소, K=2→K=4 등)은 당시 데이터 기준의 기록이며, 이하의 수치는 2026.07.18 검증본의 재산출값이다.

■ 사각지대 107개소 → 414개소: 왜 달라졌는가

두 수치의 차이는 모델 개선의 효과만으로 발생한 것이 아니라, 공급 기준·좌표 품질·데이터 버전이 함께 바뀐 결과다. 실행 버전별 조건은 다음과 같다.

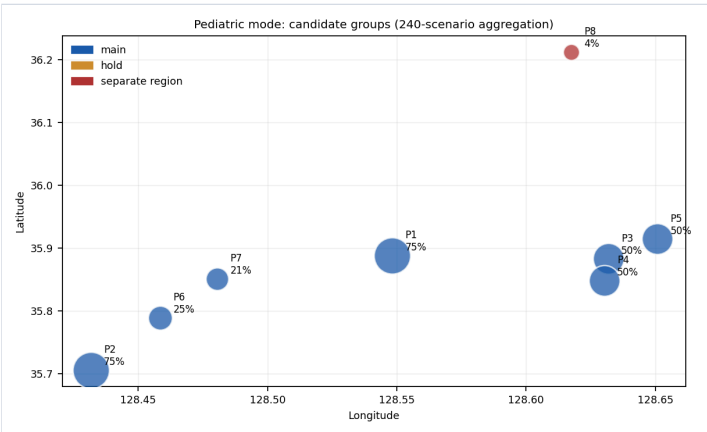
실행 버전	공급기관 수	지오코딩 방식	실패 주소 수	사각지대 수	주된 변경 원인
초기(v1)	달빛 4개소	Nominatim 초기 변환	기록 미보존	107개소	—
최신(v2)	달빛 6개소	Nominatim + 캐시 재구축·좌표 정비	기록 미보존	414개소	공급 명단 공표본 대조, 주요 좌표 정비, 데이터 버전 변경

공급 기관이 늘었음에도 사각지대가 확대된 것은 좌표 정비로 주요 지점의 실제 위치가 드러난 영향이 큰 것으로 보이나, 두 수치는 서로 다른 공급 명단·좌표자료·전처리 조건에서 산출된 과거 개발 기록으로, 입력 버전과 실패 주소 기록이 완전히 보존되지 않아 직접적인 시계열 비교나 원인별 기여도 분해에는 사용할 수 없다. 현행 파이프라인은 좌표 변환에 실패한 주소를 임의 좌표로 대체하지 않고 분석 대상에서 제외하는 규칙을 사용하며, 최종 수치는 공식 주소 API 재지오코딩과 실패 건 처리 방식에 대한 재검증을 거쳐야 확정치가 된다(V장 1절, VII장).

<표 5> 소아 모드 정책 후보 현황 (2026.07.18 검증본)

후보	분류	분석 수	민감도 반복률	가중 평균 ETA 기준(6개소) → 후보 추가 시	개선 폭(분)
후보 1	본시가지 안정	111	75.0%	15.93 → 14.41	+1.52
후보 2	본시가지 안정	26	75.0%	15.93 → 15.92	+0.01
후보 3	본시가지 안정	274	50.0%	15.93 → 15.22	+0.71
후보 4	본시가지 안정	121	50.0%	15.93 → 14.94	+0.99
후보 5	본시가지 안정	117	50.0%	15.93 → 15.70	+0.23
후보 6	별도 권역(군위)	3	4.2%	15.93 → 15.80	+0.13

주: ETA는 0~9세 취약인구(126,483명, 2026.06 기준월) 가중 평균이며, '기준'은 Tier 3 6개소만 있을 때, '추가 시'는 해당 후보 1개를 더했을 때의 값이다. 분석 수치는 실제 환자 수가 아니라 후보 산출에 사용된 취약 수요 묶음의 규모다. 본 결과는 현장조사·전문가 검토 전의 잠정 산출로 확정 입지가 아니다. 자료: 이현석(2026q) policy_release.json.



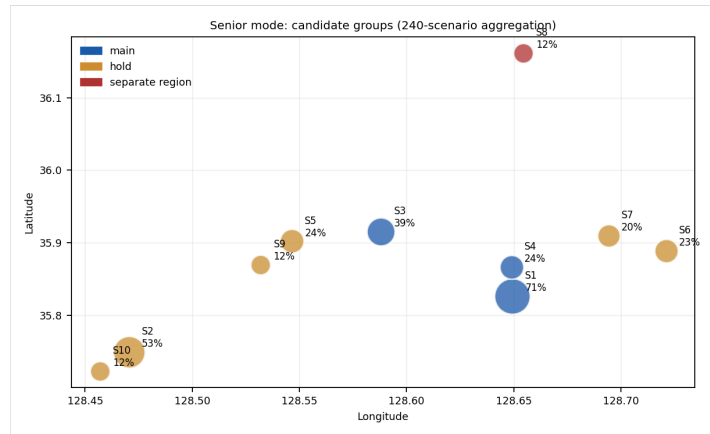
<그림 6> 소아 모드 후보 좌표와 민감도 반복률. 원의 크기는 반복 출현율에 비례하며, 파랑은 대구 본시가지 후보군, 빨강은 군위 별도 권역 후보이다. 행정동 경계·도로망을 표시하지 않은 좌표 산점도이며, 경계가 포함된 대화형 지도는 서비스 대시보드에서 제공한다. 라벨 P1~P8은 민감도 분석의 후보권 식별자로, 2026.07.18 검증본은 이 분류(반복률 포함)를 승계한다. 자료: 이현석(2026n).

어르신 모드의 기준 기관은 권역·지역응급의료센터(Tier 1·2) 19개소로, 기준 기관만 있을 때 65세 이상 취약인구 가중 평균 ETA는 11.89분이다. 실제로 ETA 기반 VDI에서 위험 기준점(상위 25% 상대 기준, 13,261.43) 이상으로 진단된 고위험 행정동은 38개이며(그림 5), 민감도 분석에서 분류·승계된 어르신 후보는 3개(본시가지 안정 1·보류 1·별도 권역 1)다. 후보별 개선 폭은 <표 6>과 같다 — 소아 모드보다 기준 접근성이 좋아 개선 폭의 절대값은 작으나, 이는 기관 수(19 대 6)와 문제 성격의 차이를 반영하는 것으로 두 모드를 단일 척도로 비교하지 않는다(III장 3절).

<표 6> 어르신 모드 정책 후보 현황 (2026.07.18 검증본)

후보	분류	분석 수	민감도 반복률	가중 평균 ETA 기준(19개소) → 후보 추가 시	개선 폭(분)
후보 1	본시가지 안정	12	70.8%	11.89 → 11.51	+0.38
후보 2	보류(hold)	5	53.3%	11.89 → 11.81	+0.08
후보 3	별도 권역(군위)	8	12.5%	11.89 → 11.62	+0.27

주: ETA는 65세 이상 취약인구(529,419명, 2026.06 기준월) 가중 평균. 보류 후보는 민감도 반복률은 있으나 수요 규모가 작아 우선순위 재검토가 필요한 후보다. 본 결과는 현장조사·전문가 검토 전의 잠정 산출로 확정 입지가 아니다. 자료: 이현석(2026q) policy_release.json.



<그림 7> 어르신 모드 후보 좌표와 민감도 반복률. 파랑은 대구 본시까지 안정 후보, 황색은 보류(hold) 후보, 빨강은 군위 별도 권역 후보이다. 표기 방식과 자료 출처는 그림 6과 같다.

두 모드의 결과는 세 가지 함의를 갖는다. 첫째, 동일한 엔진이 수요·공급 정의에 따라 서로 다른 후보 구성과 성과 구조를 산출한 것은 모델이 데이터의 공간 구조에 반응한다는 것을 보여주는 관찰이다 — 다만 이를 모델 타당성의 검증으로 확대 해석하지는 않는다(III장 3절). 둘째, **서남부 권역에서 소아 후보(후보 2)와 어르신 보류 후보(후보 2)가 나란히 도출된** 것은 세대 통합형 검토의 후보 신호로, 하나의 부지·시설로 두 취약 집단을 함께 검토할 여지를 시사한다. 셋째, **군위 권역은 소아·어르신 양 모드 모두에서 별도 권역 후보로 확인되어**, 편입 지역 의료 인프라 계획이 세대 공통의 검토 과제임이 드러났다. 모드별 결과는 릴리스 산출물(policy_release.json)과 대시보드 정책맵의 후보 패널·검토 모달로 연계된다.

산출물의 형태가 갖는 의미도 작지 않다. 분석 결과가 보고서 속 정적 지도가 아니라 **상시 접근 가능한 웹 대시보드**로 제공됨으로써, 정책 결정권자·시민이 동일한 화면에서 사각지대의 위치와 규모, 거점 배치의 논리를 직관적으로 확인할 수 있다. 자원 배분을 둘러싼 논쟁이 "우리 지역도 필요하다"는 당위의 경쟁에서 "이 시설들이 실제로 권역 밖에 있다"는 사실의 확인으로 이동할 수 있는 조건이 마련되는 것이다.

4. 서비스의 안전 설계와 두 트랙의 구분

본 서비스는 시민을 위한 **Track 1 「진단」**과 정책 담당자를 위한 **Track 2 「골든 거버넌스」**를 용도가 다른 화면으로 명확히 구분하여 운영한다. Track 1은 현재 위치 기반의 병원 검색, 거리·ETA 표시, 전화·길찾기 연계, 병상·진료 정보 제공을 목적으로 하는 시민 서비스이며, Track 2의 VDI·정책 후보·p-median·MCLP 결과는 시민이 응급실을 선택하는 순간에 참조하는 실시간 의사결정 도구가 아니라 지방정부의 자원 배분 검토를 지원하는 정책분석 자료다. 두 트랙은 목적·갱신 주기·이용 대상이 다르므로 화면상으로도 분리하여 제공한다.

Track 1의 병상·진료 가능 정보는 병원 시스템과의 준실시간 연동 또는 주기적 캐시에 의존하며, 이는 특정 시점의 확인 결과일 뿐 그 순간의 실제 수용 가능성을 보장하지 않는다. 조회에 실패했거나 최근 확인된 정보가 없는 경우도 '수용 불가'나 '진료 불가'를 의미하지 않으므로, 화면에는 조회 실패·정보 미확인 상태를 수용 불가와 구분하여 표시한다. 공공 API 통신이 불안정할 때는 병원 기본정보(위치·연락처·진료과목 등)와 마지막으로 확인된 정보로 자동 대체(폴백)하며, 이 경우에도 정보의 기준 시점을 함께 표시한다.

아울러 화면에 표시되는 수치 가운데 확정 공공데이터·자체 산출값에 근거한 항목과, 실자료 연계 전 단계의 검증용 예시 데이터인 항목은 <표 2> 데이터 상태표의 구분을 따른다. 임의로 꾸며낸 값을 상시 노출하지는 않으나, 일부 화면 요소는 실자료 연계 전까지 구조 시연을 위한 예시값을 사용하며 이 사실은 해당 화면에 고지된다 — 즉 화면에 표시되는 값을 임의로 꾸며내지 않는다는 원칙과 일부 화면 요소가 예시 데이터라는 사실은 서로 다른 항목을 가리키는 것으로, 어떤 화면 요소가 어느 쪽에 해당하는지는 <표 2>에 따라 판단한다.

본 서비스는 119 신고 체계를 대체하지 않으며, 실제 응급 상황에서는 119 또는 응급의료 정보센터(1339)로 연락할 것을 서비스 전면에 고지한다. 지도상 거리·색상·병상 정보는 참고용이며 실제 이동 시간과 수용 가능성은 도로·교통 상황과 병원 현장 사정에 따라 달라질 수 있음을 함께 명시하여, 정보 서비스가 응급 대응 행동을 오도하지 않도록 하는 안전 설계를 채택하였다. 출발 전 전화로 병원에 재확인할 것을 권고하는 안내도 함께 제공한다.

V. 정책 제언

1. 단기: 공식 데이터 검증, 재지오코딩, 관계기관 공동 검토

모든 후속 제언에 선행하는 단기 과제는 데이터의 공식화다. 구체적으로 ① 보육시설 주소 전량을 국가 공식 주소 API로 재지오코딩하고(변환 실패 건은 분석 제외 후 별도 보고), ② 병원 기본정보의 수집일과 출처를 원본 다운로드 기록으로 개별 확인하며, ③ 파이프라인을 전면 재실행하여 본 보고서의 산출을 재검증하는 것이다. 이 단계는 관계기관과의 자료 협의만으로 착수할 수 있으며, 이후의 어떤 배치 대안도 이 단계 없이는 집행 근거를 갖지 못한다. 재산출 결과가 현행 후보권과 어긋날 경우 후보권을 갱신하는 것 자체가 본 모델이 의도한 작동 방식이다.

2. 중기 후보 대안: 기존 기관 보강·이동형 진료·의료인력 확충의 검토

본시까지 안정 후보(<표 5>·<표 6>)와 같이 인근에 기존 의료기관이 이미 위치한 후보권에 대해서는, 해당 기관의 인력·장비 보강을 지원하는 방안을 검토할 수 있다. 신규 건립 없이 기존 기관의 역량을 끌어올리는 방식이므로 거점 신설 대비 소요 재정과 착수 기간이 상대적으로 짧을 것으로 예상되나, 구체적인 보강 대상과 규모는 심평원 등 공식 자료로 병원별 인력·장비 현황을 확인한 뒤 별도로 산정해야 한다.

보류·별도 권역 후보와 같이 인근의 기존 의료기관 분포가 상대적으로 희박한 후보권에 대해서는, 의료 장비와 인력을 탑재한 이동형 진료 차량을 야간·휴일에 순환 배치하는 방안을 검토할 수 있다. 점차 지점은 각 거점 인근의 공영주차장·공공청사 부지 등을 후보로 검토하고, 소아·어르신 수요가 겹치는 권역은 세대 통합 운영을 함께 고려할 수 있다.

아울러 후보권 인근에 개원하거나 야간·휴일 진료로 전환하는 의료기관에 대한 지원(임대료·야간 운영 인건비·시설 개보수비 등)과 야간·휴일 소아과 유지 인센티브도 검토 대안으로 제시할 수 있다. 다만 **이동형 진료, 기존 기관 보강, 의료인력 확충** 등은 본 모델이 산출한 확정 결과가 아니라 후보지역에 대해 향후 관계기관이 검토할 수 있는 정책 대안의 예시다. 본 분석은 필요한 전문의 수, 장비 수량, 예산을 산출하지 않는다. 지원 기간·비율·의무 운영시간 등 세부 조건은 유사사업 조사, 재정 여건 분석 및 관계기관 협의를 거쳐 별도로 결정되어야 하며, 이는 달빛어린이병원의 '반쪽 운영' 문제(메디칼업저버, 2025)에 대한 사전 예방 장치로도 검토될 수 있다.

3. 장기: 시범사업 평가와 연례 재분석의 제도화

커버 성과가 가장 큰 후보 조합(표 8의 30분 MCLP 기준)을 우선 후보로 검토하여 1년간 시범 운영한 후, 이용 건수·응급실 경증 내원 감소율 등 성과지표를 평가하여 잔여 거점으로 확대하는 방안을 검토할 수 있다. 다만 극소의 거점(군위읍)은 이용 건수 기준의 성과 평가가 구조적으로 불리하므로, 접근 시간 단축·미충족 의료 해소 등 형평성 지표를 별도로 적용한다. 아울러 파이프라인을 연 1회 재실행하여 의료기관 개·폐업 변동을 반영한 사각지대 재산정과 거점 재조정을 제도화한다. 이로써 분석은 일회성 산출물이 아닌 지속 갱신되는 행정 자산이 된다.

4. 교차 활용: 어르신 모드 결과와 세대 통합형 후보

어르신 모드의 후보 3개(본시까지 안정·보류·별도 권역)는 노인 심뇌혈관·낙상 응급의 병원 전(前) 단계 대응 — 구급 거점 재배치, 이송 체계 보강, 낙상 예방·응급 대응 교육 거점 — 을 논의하는 근거로 활용할 수 있다. 특히 소아 후보 2와 어르신 후보 2(보류)가 **같은 서남부 권역에서 나란히 도출**되었고 두 곳 모두 주변 참조 기관 신호가 약하므로, 소아 야간진료와 노인 응급 대응 기능을 겸하는 세대 통합형 거점을 이 권역에 우선 검토할 것을 제안한다. 하나의 부지·시설로 두 취약 집단을 함께 커버하므로 예산 효율과 형평성을 동시에 충족하며, 군위 권역 역시 세대 공통의 별도 권역 후보로 확인된 만큼 편입 지역 의료 인프라 계획에 두 모드의 결과를 함께 반영할 필요가 있다.

<표 7> 정책 제언별 검토 프레임

구분	후보 대안	해결하려는 문제	필요한 데이터	담당 가능 기관	예상 제약	평가 지표(안)
단기 (1단계)	공식 데이터 검증·재지오큐딩·관계기관 공동 검토	추정·예시 데이터 기반 잠정 결과의 신뢰 확보	심평원 확정 인력·장비 자료, 공식 주소 API	시 보건 부서, 심평원, 시 데이터 부서	자료 제공 절차와 시차	검증 완료율, 재산출 결과의 변동 폭
중기 (2단계)	후보 대안 ① 기존 병원 표적 보강	병원은 있으나 역량이 부족한 후보권	검증된 인력·장비·운영시간 자료	시 보건 부서, 해당 의료기관	재정 협의, 의료인력 채용 여건	보강 전후 야간·휴일 수용 실적
중기 (2단계)	후보 대안 ② 이동형 클리닉 순환 배치	반경 내 병원이 전무한 절대 공백 후보권	현장조사 결과, 점차 가능 부지 목록	시, 관할 보건소, 지역 의료기관(위탁)	인력 확보, 운영비 (유사사업 단가 조사 후 산정)	접근 시간 단축, 이용 실적, 미충족 의료 해소
중기 (2단계)	후보 대안 ③ 야간·휴일 소아과 유지 인센티브	후보권 인근 민간 공급의 유인 부족	개원 수요 조사, 유사 지자체 사업 단가	시(재정), 구·군 (행정지원), 의사회	지정 취소·축소 운영 재발 위험	야간 진료 유지율, 달빛 지정 유지
장기 (3단계)	시범사업 평가·연례 재분석 제도화	일회성 분석의 진부화, 개·폐업 변동 미반영	갱신 명단·인구 통계, 이송·이용 자료	시 공공보건의료지원단, 대학·연구기관	예산·조직의 지속성	재분석 주기 준수, 사각지대 변화 추이

주: 소요 재원은 근거 있는 단가 조사가 선행되어야 하므로 본 표에서 제시하지 않으며, 유사사업 단가 조사 후 별도로 산정한다. 단계 구분은 확정 일정 아닌 예시적 로드맵이며, 모든 대안은 단기(1단계) 데이터 검증의 결과에 따라 조정된다.

VI. 논의: 사회과학적 의의

1. 거버넌스: 순환형 민관 협치로의 발전 가능성

본 프로젝트의 첫 번째 의의는 공동생산 이론이 기술하는 협치의 순환 구조 가운데 **시민의 분석·제안 고리**를 실제 작동 가능한 형태로 구현했다는 점이다. 행정이 데이터를 공개하고, 시민이 이를 분석하여 정책 대안을 생산하며, 행정이 이를 검토·검증하고 그 결과가 다시 데이터로 환류되는 구조로 이어진다면, 이는 공동생산론(Ostrom, 1996; 권향원·윤영근, 2020)이 기술하는 이념형에 근접해 갈 수 있다 — 현재 도달 지점은 그 첫 고리다. 특히 분석 파이프라인이 코드 수준에서 공개·재현 가능하므로, 시민의 기여가 '의견'이 아니라 검증 가능한 '분석 자산'의 형태로 행정에 이전된다. 구조의 범용성에 대해서는, 소아 모드로 구축된 동일한 분석 엔진이 수요·공급 정의만 바꾼 어르신 모드에서 상이한 결과(K=3)를 산출함으로써, 재난 대피소 배치 등 공간 배분이 쟁점인 다른 정책 대상에 적용할 수 있는 구조적 가능성이 프로젝트 내부에서 확인되었다.

아울러 본 프로젝트가 지방정부(대구 수성구)가 주최하는 지역 SW 인재 양성 과정의 교육생 프로젝트에서 출발했다는 사실은 별도의 함의를 갖는다. 지역 인재 양성 정책은 통상 '취업 연계'라는 노동시장 성과로 평가되지만, 본 사례는 교육 과정에서 습득한 데이터 분석·개발 역량이 지역의 공공문제 해결로 곧바로 환류될 수 있음을 보여준다. 즉, 인재 양성 사업(수성알파시티) → 교육생의 지역 문제 분석(본 프로젝트) → 지방정부의 정책 검토(제안된 협의체·시범사업)로 이어질 수 있는 경로는, 지역 디지털 인재 정책과 데이터 기반 행정이 결합하는 **이중의 공동생산**으로 발전할 수 있는 구조로서, 유사 교육 사업의 성과 설계에도 참고할 수 있는 모델이다.

사회적 자본의 관점(Putnam, 1993)에서 보면 이 순환의 가치는 더욱 분명해진다. 공동 검증 협의체, 대시보드의 상시 공개, 연례 재분석의 제도화는 각각 정부-시민 간 반복적 상호작용의 장치로서, 일회적 협력을 지속적 신뢰 관계로 전환시키는 사회적 자본 축적 메커니즘으로 기능할 수 있다. 그렇게 축적되는 신뢰와 관계망은 사업의 성과와 무관하게 지역에 남아, 이후의 협치 시도가 더 낮은 비용으로 출발할 수 있게 하는 무형의 기반이 될 수 있다.

2. 형평성: 규범의 조작화

두 번째 의미는 수평적 형평성이라는 규범적 원칙을 공간 연산으로 조작화하여 집행 가능하게 만들었다는 점이다. "동등한 필요에 동등한 접근을"이라는 원칙은 그 자체로는 배분 결정을 안내하지 못하지만, "3km 권역 밖 시설의 아동에게 우선 배분"이라는 연산 규칙으로 번역되는 순간 예산 항목과 입지 좌표로 구체화된다. 이는 사회과학의 규범 이론과 데이터 과학의 계산 기법이 결합할 때 형평성 논의가 실행력을 얻는다는 것을 보여주는 사례이다.

나아가 VDI 가중 파인튜닝의 결과는 이 조작화가 배분 결과를 실제로 바꾼다는 것을 보여준다. 수요 밀집도만 반영한 기초 모델은 효율성 논리에 따라 거점을 인구 밀집지에 집중시켰고, 그 결과 가장 취약한 최북단 지역이 배제되었다. 취약도를 가중치로 주입하자 수요 3개소에 불과한 이 지역(군위읍)이 독자 거점으로 부상하였다. 이는 "알고리즘은 중립적"이라는 통념과 달리 **가중치 설계 자체가 효율성·형평성 간 가치판단의 산물임**을 보여주며, 공공부문 AI 활용에서 모델 설계 과정의 공개와 숙의가 왜 필요한지를 보여주는 경험적 근거가 된다.

'거리의 독재'의 진단과 교정(III장 4절, IV장 2절)은 이 논점을 한 단계 더 밀고 나간다. 가중치의 배분만이 아니라 **지표의 산식 그 자체** — 변수를 곱할 것인가 더할 것인가, 로그를 취할 것인가 — 가 어떤 지역의 위험을 보이게 하고 어떤 지역의 위험을 지우는가를 결정하는 가치 배분의 문제였기 때문이다. 주목할 것은 실패의 양상이다. 스케일을 보정하지 않은 원시 지표를 주입받은 군집 분석 파이프라인은 오류 메시지 하나 없이 정상적으로 작동하면서, 도심의 핵심 사각지대를 안전지대로 표기한 그럴듯한 지도를 산출하였다. 데이터 기반 행정의 실패는 흔히 상정되듯 시스템 장애의 형태가 아니라 **정상 작동하는 시스템이 산출한 왜곡된 확신**의 형태로 도래하며, 그것을 교정하는 것은 더 크고 복잡한 모델이 아니라 변수의 분포를 들여다보는 기초적인 통계적 성찰이라는 것 — 이것이 본 사례가 데이터 기반 행정 일반에 주는 교훈이다. 만약 이 보정 없이 초기 산출을 그대로 정책에 반영했다면, 행정은 알고리즘의 권위를 빌려 외곽에만 자원을 배분하고 도심의 '병상 수배 뱅뱅이' 지역을 방치하는 오류를 데이터의 이름으로 정당화했을 것이다.

이러한 책임성의 요구는 분석 모델만이 아니라 **개발 과정 자체**에도 적용된다. 본 프로젝트는 AI 도구와의 협업 과정에서 발생한 오류들 — 미설치 라이브러리 참조, 타입 검증 생략, 아키텍처 원칙 위반 등 — 의 근본 원인을 자체 진단 보고서로 문서화하고, "아무것도 가정하지 말고 모두 검증하라"는 검증 규율과 사후 검증 절차를 명문화하였다(이현석, 2026g). 이는 AI가 생성한 산출물을 공공 의사결정의 근거로 삼으려 할 때 요구되는 품질 관리와 책임 소재 기록의 실무적 선례로, 도구의 산출물을 무비판적으로 수용하지 않는 통제 절차가 프로젝트 수준에서도 운영 가능함을 보여준다.

모델 선택 자체도 같은 책임성의 논리 위에 있다. 본 프로젝트는 예측 성능이 더 높을 수 있는 심층학습 대신 K-Means와 명시적 가중치 공식을 의도적으로 채택했는데, 그 근거는 "공공 정책 도구는 왜 이 결론이 나왔는지를 행정관이 의회에 보고할 수 있어야 한다"는 것이다(이현석, 2026h). 가중치 항(VDI)이 공개된 수식으로 표현되므로 의사결정 경로의 감사(audit)가 가능하고, 이해관계자가 산식의 특정 요소를 문제 삼으면 그 요소만 조정해 재실행할 수 있다. 설명가능성이 사후 해석 기법(XAI)의 문제가 아니라 **모델 선택 단계의 설계 기준**이 될 수 있음을 보여주는 사례로, 공공부문 AI 논의에 시사하는 바가 있다.

3. 예산 효율성: 타겟팅의 경제성

세 번째 의미는 재정적 효율성이다. 전 지역 무차별 확충 방식과 달리 사각지대로 판정된 후보권에 재원을 집중하면 동일 예산 대비 접근성 개선 효과를 높일 수 있다. 군집 중심점은 취약도 가장 수요지점에 대한 제공거리 합을 최소화하는 공간적 중심이므로 투입 대비 수혜 범위가 넓을 것으로 기대되고, 이동형 클리닉의 단계적 도입은 상설 기관 설립 대비 초기 투자 위험을 낮춘다. 아울러 경증 소아 환자의 권역응급의료센터 내원이 감소하면 응급실 과밀 완화에 따른 사회적 비용 절감이라는 간접 효과가 수반되며, 이는 병원 간 이송이 소아 사망률을 유의하게 높인다는 임상 증거(데일리메디, 2023)에 비추어 건강 결과의 개선으로도 이어질 수 있다.

VII. 연구의 한계와 향후 과제

본 보고서는 프로젝트의 한계를 명시적으로 밝히는 것이 증거기반 접근의 일부라는 입장에서 다음을 기록한다.

첫째, 직선거리 기반 분석의 한계이다. 3km 버퍼와 Haversine 거리 모두 직선(대원)거리를 기준으로 하므로 하천·산지·도로망에 의한 실제 이동 경로의 우회를 반영하지 못한다. 향후 도로망 네트워크 분석 및 시간대별 실제 주행시간(예: 내비게이션 API) 기반의 등시선(isochrone) 분석으로 고도화할 필요가 있다. 이 가운데 후보 평가 단계에 한해서는 실제 도로 ETA 기반 p-median·최대 커버리지 입지 문제(MCLP)의 정확 탐색이 분류된 정책 후보군에 한해 통합 정책 입지 모델로 도입되었다(IV장 2절, 표 8). 다만 고도화 이후에도 한계는 남는다 — 도로 ETA는 수집 시점의 스냅샷이고, 급급차 우선 통행과 실제 출동 기록은 반영되지 않으며, 최적조합은 후보군 내부의 해일 뿐 전역 최적해가 아니고, 사각지대 필터링 단계 자체는 여전히 3km 직선거리 기준이다. location-allocation 확장과 후보 부지 제약조건(부지 확보 가능성, 토지이용 규제)의 반영은 향후 과제로 남는다.

둘째, 수요 대리지표의 한계이다. 보육시설 분포는 미취학 아동의 주간 생활권을 근사하지만, 야간 응급 수요의 발생 지점은 주거지이며 보육시설에 등원하지 않는 아동은 포착되지 않는다. 또한 현행 모델은 행정동 취약도(VDI)를 가중치로 반영하나 시설별 정원(아동 수)은 반영하지 않아, 시설 규모의 차이가 수요량에 나타나지 않는다. 주민등록 연령별 인구 격차자료와의 결합 및 정원 가중의 병행이 향후 과제이다.

셋째, 지오코딩 정확도의 한계이다. 현 구현은 OpenStreetMap 기반 Nominatim을 사용하며, 좌표 변환에 실패한 주소는 임의 좌표로 대체하지 않고 분석 대상에서 제외한다. 다만 이는 실패 주소가 수요 데이터에서 그대로 누락됨을 의미하므로, 실패 주소의 공간적 분포에 따라 사각지대·군집 중심의 위치가 과소 또는 과대 추정될 가능성이 있다. 실운영 단계에서는 국가에서 제공하는 공식 주소 좌표 변환 서비스(도로명주소 API 등)로 재지오코딩하고, 제외된 주소 목록을 별도로 보고하는 것이 타당하다.

넷째, 지표 설계와 모델 검증의 한계이다. 군집 수는 엘보 기법으로 도출하였으나 실루엣 계수 등 보완적 검증은 아직 수행되지 않았고, 가중치의 원천인 VDI의 산정 방식이 결과 전체를 좌우한다. VDI는 듀얼 보정(III장 4절)으로 스케일 왜곡을 교정하였으나, 자연로그라는 변환 함수의 선택과 Min-Max 모델의

5:5 결합비는 여러 방어 가능한 대안 가운데 하나이며, 거리·인구 외의 구성 변수(소득, 교통 여건, 병원 전 단계 대응 자원 등)로의 확장 여지도 남아 있다. 요컨대 현행 결과는 채택한 지표 설계의 **작동 방식을 보여준 것**이 유일하게 타당한 설계라는 의미가 아니며, 대안 설계와의 비교·검증이 향후 과제로 남아 있다(이현석, 2026I).

다섯째, 산출 수치의 변동성이다. 사각지대 규모는 초기 산출(달빛 4개소·초기 지오코딩 기준 107개소)에서 최신 산출(6개소·정비 데이터 기준 414개소)로 데이터 정비 단계마다 크게 재산정되어 왔다. 공급 기관이 늘었음에도 사각지대가 확대된 것은 좌표 정비로 수요 지점의 실제 위치가 드러난 영향이 큰 것으로 보이나, 변동의 요인별 기여분(공급 명단 변경분과 좌표 정비분의 분리)을 정량적으로 규명하는 작업이 남아 있다. 따라서 본 보고서의 수치는 확정치가 아니라 행정과의 공동 검증을 전제로 한 최신 산출값이며, 이러한 변동성 자체가 V장에서 제안한 연례 재분석 제도화의 경험적 근거이기도 하다. 실제로 2026년 7월 중의 명단 검수에서 응급 관련 기관 1개소(계명대학교대구동산병원)의 누락이 발견되었고, 보완 명단(25개소) 기준으로 파이프라인 전체가 재실행·검증되어 본 보고서가 그 2026.07.18 검증본을 기준으로 작성되었다 — 공급 명단의 정기 검수와 재분석 제도화가 필요한 이유를 프로젝트가 직접 경험하고 처리한 사례다.

여섯째, 어르신 모드 고유의 한계이다. 반경 3km(자가 차량 약 10분) 기준은 본래 소아 보호자의 이동을 상정한 것으로, 노인 중증 응급(심뇌혈관 등)은 구급차 이송과 병원 전 단계 대응이 핵심이어서 거리 기준과 임계값의 재검토가 필요하다. 또한 행동 중심점을 수요 지점으로 삼는 방식은 면적이 넓은 외곽 행정동에서 실제 거주지 분포와 괴리될 수 있어, 인구 격자 단위 수요로의 정밀화가 향후 과제이다.

일곱째, 현 단계 데이터의 성격이다. Track 1 화면의 거리·수치 일부는 실자료 연계 전의 검증용 예시 데이터이다. 서비스는 이를 명시 고지하고 있으며, 로드맵 2단계(실제 병원·병상·인구 자료 교체 및 사각지대 판단 기준 확정)가 완료되기 전까지 본 보고서의 결과 해석 역시 방법론의 작동을 보여주는 것에 한정된다.

여덟째, 결과 검증 자료의 부재이다. 실제 응급 이송 기록, 병상 수배(재이송) 자료, 사망·예후 자료와의 대조가 수행되지 않아, 본 분석이 식별한 사각지대와 후보권이 실제 응급의료 결과(outcome)와 어느 정도 정합하는지에 대한 임상적 타당성 검증은 이루어지지 않았다. 이 자료들은 행정·의료기관과의 협력 없이 확보할 수 없으므로, 공동 검증 단계의 핵심 과제로 남는다.

끝으로, 위의 모든 한계는 **기준시점의 한계**이기도 하다. 본 보고서의 수치는 2026년 7월 시점의 데이터와 가정 위에서 산출된 것으로, 병상·수용 정보 같은 변동 정보와 월간 갱신되는 인구 기준자료, 변경 가능한 기관·행정구역 자료가 달라지면 VDI·위험지역·후보권·자원 시나리오도 재분석을 통해 달라질 수 있다. 이는 분석의 결합이 아니라 정상적인 갱신 과정이며, 새 결과는 검증을 거치기 전까지 본 검증본을 대체하지 않는다(일러두기 하단 안내 참조).

VIII. 결론

'대구 골든타임' 프로젝트가 **실제로 구현한 것**은 다음과 같다. 국가 표준 좌표계 기반의 공간 연산과 반경 3km 시나리오에 의한 사각지대 필터링, 취약성 지수(VDI) 가중 K-Means에 의한 후보권 생성, 240개 시나리오 민감도 분석에 의한 안정 후보의 선별, 그리고 분류된 정책 후보군에 대한 실제 도로 ETA 기반 p-median·MCLP 조합 탐색이다. 분석 과정에서 **발견한 것**은 초기 VDI 산식의 스케일 왜곡('거리의 독재')이 도심 밀집 사각지대의 위험을 데이터 위에서 지우고 있었다는 사실이고, **수정**한 것은 그 산식(로그 보정과 Min·Max 보조 지표)과 하류의 임계 체계, 그리고 K-Means 산출물의 지위(확정 입지 → 1차 후보) 자체다. **현재 결과가 의미하는 것**은 현행 2026.07.18 검증본의 데이터와 명시된 가정 아래에서 후속 검토의 우선순위가 어디를 향해야 하는가이며, **아직 확정할 수 없는 것**은 개별 좌표의 입지 타당성과, 현장조사·전문가 검토를 거치기 전 후보권의 실제 정책 우선순위다. **다음 검증 단계**는 공식 데이터 연계와 재지오코딩, 복수 반경 시나리오와 도로망 기반 이동시간 분석, 그리고 행정·전문가의 공동 검토다(V장·VII장). 덧붙여 본 보고서의 모든 수치는 2026년 7월 기준시점의 스냅샷으로 보존되며, 원천 데이터의 갱신과 검증을 거친 재분석은 이 기록을 수정하는 것이 아니라 새로운 판본으로 이어진다 — 연례 재분석의 제도화(V장)가 그 경로다.

사회과학의 관점에서 이 프로젝트의 본질은 기술이 아니라 거버넌스다. 시민이 공공데이터로 정책 대안을 제안하고, 형평성 규범을 명시적 수식으로 조작화하며, 분석 논리 전체를 공개하여 제3자의 검증에 여는 것 — 그리고 자신의 지표가 낳은 왜곡을 스스로 진단하고 교정한 과정까지 기록으로 남기는 것이다. 대구 골든타임의 최종 성과는 하나의 확정 좌표가 아니라, 어떤 데이터를 어떤 가치 기준으로 결합하느냐에 따라 정책 우선순위가 달라질 수 있음을 공개하고 검증 가능한 형태로 제시한 데 있다.

주석 — 용어 해설

- 1) **단계구분도(choropleth)**: 행정동 같은 구역 단위 지도에서, 수치의 크기를 색의 진하기로 표현해 지역 간 차이를 한눈에 비교할 수 있게 하는 지도 기법.
- 2) **취약성 지수(VDI, Vulnerability Index)**: 의료기관까지의 거리, 인구 구성 등 여러 요소를 결합해 "이 지역이 의료 접근에서 얼마나 불리한가"를 행정동 단위의 하나의 숫자로 나타낸 지수. 본 프로젝트에서는 당초 '최근접 병원 직선거리 × 취약인구'로 산출하였으나 스케일 왜곡('거리의 독재') 진단 후 거리에 자연로그를 취한 산식 $(\ln(1+거리) \times 취약인구)$ 로 재설계하였다(III장 4절).
- 3) **지오코딩(geocoding)**: "동구 ○○로 12"와 같은 문자 주소를 지도 위에 표시할 수 있는 위도·경도 좌표로 변환하는 작업. 반대로 좌표를 주소로 되돌리는 것은 역지오코딩(reverse geocoding)이라 한다.
- 4) **평면직각좌표계(EPSG:5179)**: 위도·경도는 각도 단위여서 그대로 거리를 계산하면 왜곡이 생기므로, 지구 곡면을 평면에 투영해 미터(m) 단위로 정확히 잴 수 있게 만든 대한민국 표준 좌표 체계. EPSG는 전 세계 좌표계마다 부여된 국제 표준 번호이다.
- 5) **버퍼(buffer)**: 지도 위의 한 지점을 중심으로 일정 반경의 원형 영역을 생성하는 GIS 연산. 본 보고서에서는 병원을 중심으로 한 반경 3km 원을 '실효 서비스 권역(안전망)'의 의미로 사용한다.
- 6) **공간 결합(spatial join)**: 두 지도 데이터를 '위치가 겹치는가'를 기준으로 연결하는 연산. 여기서는 각 보육시설이 어느 병원의 3km 권역 안에 포함되는지를 판정하는 데 사용되었다.
- 7) **Haversine 공식**: 지구가 둥글다는 점을 반영하여, 두 지점의 위도·경도만으로 지표면을 따라가는 최단 거리(대원거리)를 구하는 공식. 지도를 평면으로 가정하고 자로 재듯 직선거리를 계산하면 지구 곡률 때문에 오차가 생기는데, 이를 보정한 거리 계산법이다.
- 8) **K-Means 군집화(clustering)**: 흩어져 있는 점들을 서로 가까운 것끼리 K개의 무리(군집)로 묶고 각 무리의 중심점을 찾아주는 기계학습 기법. 중심점은 무리에 속한 점들까지의 거리 제곱합이 최소가 되는 위치, 즉 그 무리의 '평균적 한가운데'이다.
- 9) **엘보(elbow) 기법**: 군집 수 K를 1, 2, 3...으로 늘려가며 군집의 응집도가 얼마나 좋아지는지를 그래프로 그린 뒤, 개선 폭이 급격히 꺾이는 지점(팔꿈치 모양)을 최적의 K로 선택하는 방법. K를 사람이 임의로 정하지 않기 위한 통계적 판단 기준이다.
- 10) **평균 정규화(mean normalization)와 표본 가중치(sample_weight)**: 정규화는 단위와 크기가 제각각인 수치를 평균 대비 상대값으로 바꿔 서로 비교 가능하게 만드는 절차이고, 표본 가중치는 군집 계산에서 특정 지점(예: 취약도가 높은 지역의 시설)이 더 무겁게 반영되도록 부여하는 중요도 값이다. 본 모델에서는 VDI를 정규화한 값을 가중치로 사용해, 취약한 지역일수록 거점을 끌어당기는 힘이 커지도록 설계하였다.
- 11) **자연로그(ln) 보정**: 값이 커질수록 증가 폭이 완만해지는 로그 함수의 성질을 이용해, 극단적으로 큰 값(아웃라이어)이 지표 전체를 지배하지 못하도록 억제하는 수학적 변환. 본 프로젝트에서는 "이미 골든타임을 넘긴 구간에서는 거리가 더 멀어져도 체감 위험의 차이가 작다"는 판단, 즉 원거리 극단값의 영향력을 완화하기 위한 명시적 정책 가정을 산식에 반영하는 수단으로 사용하였다.
- 12) **Min-Max 정규화(normalization)**: 어떤 수치 배열의 최소값을 0, 최대값을 1로 놓고 나머지 값을 그 사이의 비율로 환산하여, 단위와 크기가 다른 변수들을 같은 저울 위에서 비교할 수 있게 만드는 절차. 본 프로젝트에서는 거리와 인구를 각각 0~1로 압축한 뒤 5:5로 합산한 보조 지수(0~100점)를 만들어 로그 보정 지수와의 대체 산식 기반 민감도 비교에 사용하였다.

참고문헌

1. 국내 문헌

권향민·윤영근. (2020). 공공문제해결을 위한 '정책 공동생산'(co-production)의 개념적 이해 및 사례의 유형화 연구. 『한국사회와 행정연구』, 30(4), 1-26.
<https://doi.org/10.53865/KSPA.2020.02.30.4.1>

2. 국외 문헌

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95-S120.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559.

Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. *Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1-11.

Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: Synthesis and a case study in the Chicago region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6), 865-884.

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073-1087.

Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2), 127-140.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

3. 통계·행정·보도 자료

※ 언론 보도를 경유해 인용한 통계·연구는 [언론 보도]로 표기하여 공식 기관 자료와 구분하였다. 해당 수치의 최종 인용은 원 통계·원 논문의 확인을 전제로 하며, 본 보고서에서는 보도 시점의 수치로 한정하여 사용한다.

경북일보. (2026. 3. 6.). 대구 소아 의료 공백 '달빛어린이병원' 6곳 확대가 답이다. <https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4066107> (검색일: 2026. 7. 7.) [언론 보도]

대구광역시. (2026). 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 안내. 대구광역시 분야별 건강 누리집. https://www.daegu.go.kr/health/index.do?menu_id=00936060 (검색일: 2026. 7. 7.)

데일리메디. (2023). 응급실 뺑뺑이 소아, 72시간내 사망률 '1.9배 증가'(서울대병원·보라매병원·분당서울대병원 공동연구팀, 대한의학회지(JKMS) 게재 연구 보도). https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=905948 (검색일: 2026. 7. 7.) [언론 보도]

메디칼업저버. (2025). 확 늘어난 '달빛어린이병원', 소아 야간 진료 해법 뭘까?. <https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=406820> (검색일: 2026. 7. 7.) [언론 보도]

메디컬투데이. (2026). 소청과 개업 줄고 폐업 늘어…일반의 개업은 증가세(건강보험심사평가원 '의원 표시과목별 요양기관 개·폐업 현황' 보도). <http://www.mdtoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=517089> (검색일: 2026. 7. 7.) [언론 보도]

보건복지부. (2025). 2025년 소아 야간·휴일진료기관(달빛어린이병원) 운영지침. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10409020000&bid=0026&act=view&list_no=1484970 (검색일: 2026. 7. 7.)

서울경제. (2023). 아픈 아이 안고 병원 '오픈런'하는데…소아과 줄폐업에 맞붙어 부모 "이제 어떡하나". <https://www.sedaily.com/article/20011663> (검색일: 2026. 7. 7.) [언론 보도]

행정안전부. (2024). 국내 65세 이상 주민등록 인구 20% 돌파, 초고령사회 진입(2024. 12. 발표). <https://www.mois.go.kr> (검색일: 2026. 7. 9.) [언론 보도]

4. 분석·개발 기록(프로젝트 내부 문서 및 코드)

※ 아래 기록은 분석 과정의 재현과 판단 근거의 추적을 위한 것으로, 본 보고서에서 외부 타당성의 근거로는 사용하지 않는다.

이현석. (2026a). 대구 골든타임 기획서: 응급의료 거버넌스 플랫폼('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026b). 데이터 기반 소아 응급의료 사각지대 해소를 위한 신규 의료자원 전략적 배치 방안('대구 골든타임' 프로젝트 정책 제안서 초안).

이현석. (2026d). ml_blind_spot_filtering.py: Haversine 거리 기반 사각지대 필터링 모듈(Python 소스코드).

이현석. (2026e). 소아응급 최적 거점 AI 모델 구축 및 발전 과정 종합 보고서('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026f). pipeline_utils.py: 공통 유틸리티 모듈(Python 소스코드).

이현석. (2026g). 에이전트(AI)의 오류 원인 분석 및 개선 방안 자체 진단 보고서('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026h). AI 파인튜닝 방법론: 효율성과 공익의 통합 설계('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026k). 대구광역시 응급의료 관계 대시보드 프로젝트 개요(Master Overview)('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026l). 취약도 지수(VDI) 종합 검증 및 개선 보고서: 듀얼 보정 모델의 설계와 타당성 검증('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서).

이현석. (2026m). spatial_analysis.py: 행정동 취약성 지수(VDI) 듀얼 보정 산출 공간분석 모듈(Python 소스코드).

이현석. (2026n). 접근성 기반 최적입지 모델 고도화 Step 1~7 완료 보고서·후보 민감도 분석 보고서·AI 모델 동결 및 전환 계획서
·visualize_stable_policy_candidates.py('대구 골든타임' 프로젝트 내부 문서 및 Python 소스코드).

이현석. (2026o). build_accessibility_candidate_trace.py·run_candidate_sensitivity_analysis.py·build_stable_policy_candidates.py: 후보 근거 추적·민감도 분석
·안정 정책 후보 생성 모듈(Python 소스코드).

이현석. (2026p). 통합 정책 입지 모델 최종 구현 보고서: 실제 도로 ETA 행렬 및 p-median·MCLP 최적조합 탐색
·build_actual_road_accessibility.py·run_integrated_policy_pipeline.py('대구 골든타임' 분석·개발 기록 및 Python 소스코드).

이현석. (2026q). 대구 골든타임 공식 분석 릴리스 2026-07-18-r2: policy_release.json·build_policy_release.py 및 재실행 검증 기록('대구 골든타임' 분석·개발 기록 및 산출 데이터).

※ 위 내부 문서와 소스코드는 생성형 AI 도구의 보조를 받아 필자가 작성·검토한 것임(일러두기 참조).

부록. 분석 코드 구성 개요

아래 <부표 1>은 2026.07.18 검증본(2026-07-18-r2) 산출에 실제로 사용된 정책 릴리스 파이프라인을 실행 순서대로 정리한 것이다. 이전 판에 기재되었던 golden_governance_pipeline.py · golden_pediatric.py · golden_senior.py · hira_data_bridge.py · resource_simulator.py · build_stable_resource_recommendations.py 는 현재 저장소의 정책 릴리스 파이프라인에 포함되어 있지 않아 이번 판에서 제외하였다.

<부표 1> 정책 릴리스 파이프라인의 구성(2026.07.18 검증본 기준)

단계	모듈(경로)	기능
통합 실행	ai-model/run_integrated_policy_pipeline.py	Stage 1~7 전체를 순차 실행하는 통합 진입점
Stage 1	backend/scripts/spatial_analysis.py	행정동 취약성 지수(VDI) 산출을 위한 공간분석 — 인구·경계·병원 자료 결합, 로그 보정 지수 산출
Stage 2	ai-model/run_candidate_sensitivity_analysis.py	240개 시나리오 후보 민감도 분석 — 안정·보류·별도 권역 후보 분류
Stage 3	ai-model/build_stable_policy_candidates.py	민감도 분석 결과로부터 안정 정책 후보 9개(소아 6-어르신 3) 생성
Stage 4	ai-model/build_accessibility_candidate_trace.py	후보별 접근성 개선 근거 추적(candidate trace) 기록
Stage 5	ai-model/build_actual_road_accessibility.py	실제 도로 ETA 행렬 구축 및 p-median·MCLP 최적조합 탐색
Stage 6	ai-model/visualize_stable_policy_candidates.py	안정 정책 후보의 좌표·민감도 반복을 시각화 산출
Stage 7	ai-model/build_policy_release.py	단일 정책 릴리스(policy_release.json) 검증 및 생성 — 각 데이터 구간의 SHA-256 무결성 해시 포함

주: 위 8개 모듈은 policy_release.json을 산출하는 정책 릴리스 파이프라인의 구성이며, 서비스 프론트엔드·백엔드의 다른 코드는 포함하지 않는다.